Université Paris Cité

Les grands problèmes de santé en France

Pr. Corinne Alberti
Unité d'Épidémiologie Clinique
Hôpital Universitaire Robert Debré

Année universitaire 2025-2026

Université Paris Cité

La santé selon l'OMS

La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité.

Préambule à la Constitution de l'Organisation mondiale de la Santé, tel qu'adopté par la Conférence internationale sur la Santé, New York, 19-22 juin 1946; signé le 22 juillet 1946 par les représentants de 61 Etats. 1946; (Actes officiels de l'Organisation mondiale de la Santé, n ° . 2, p. 100) et entré en vigueur le 7 avril 1948. La définition n'a pas été modifiée depuis 1946.

Université Paris Cité

La santé selon l'OMS

La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité.

Conception positive de la santé : la santé est une **ressource de la vie quotidienne et non le but de la vie**; cette conception met en valeur les ressources sociales et individuelles, ainsi que les capacités physiques.

Université Paris Cité

La santé : d'un état statique à un processus adaptatif

La possession du meilleur état de santé qu'il est capable d'atteindre constitue l'un **des droits fondamentaux de tout être humain**, quelles que soit sa race, sa religion, ses opinions politiques, sa condition économique ou sociale.

C'est une **ressource** avec laquelle un groupe ou un individu peut, d'une part, réaliser ses ambitions et satisfaire ses besoins et, d'autre part, évoluer avec le milieu ou s'adapter à celui-ci :

Etat de bien être suffisant pour accomplir de façon adéquate un certain niveau d'activités physiques, mentales et sociales en prenant l'âge en considération, la santé étant l'ajustement réussi et permanent d'un organisme à son environnement
(Lalonde 1974, Canada).

Université Paris Cité

Les grands objectifs d'une politique de santé



En rapport avec les objectifs fondamentaux des systèmes de santé

Améliorer la santé de la population desservie

Assurer une protection financière contre les coûts associés à une mauvaise santé

Répondre aux attentes des gens (les traiter avec dignité)

Université Paris Cité

Améliorer la santé de la population desservie

Important : santé de la population desservie

Etat de santé moyen

Prenant en compte les différences entre les plus pauvres et les plus riches

Luttant contre les inégalités sociales de santé et réduisant les écarts

Bénéficie à tous

Ainsi, l'objectif de la bonne santé est double

La qualité : le meilleur niveau moyen réalisable

L'équité : la plus faible différence possible entre individus et entre groupes

Université Paris Cité

Les grands objectifs d'une politique de santé

Réduire

- Les décès évitables (donner des années à la vie)
- Les incapacités évitables (donner de la vie aux années)
- Les inégalités face à la santé

Améliorer la qualité de vie des personne handicapées ou malades
(quel que soit leur âge)

Université Paris Cité

Réduire le nombre décès évitables

En intervenant au niveau

Des habitudes de vie
Du système de soin
Du système de santé

Université Paris Cité

En France

Le constat a été réalisé par la **Drees, Direction de la Recherche, des Études, des Evaluations et des Statistiques**, relayé par **le Haut Conseil de la Santé Publique HCSP** en charge de la future stratégie nationale de santé (SNS)

Le Haut Conseil de la santé publique (HCSP) est une instance chargée d'apporter une aide à la décision au ministre de la Santé en réalisant des rapports sur la santé en France et en formulant des recommandations. Il a notamment pour missions de contribuer à l'élaboration, au suivi annuel et à l'évaluation pluriannuelle de la stratégie nationale de santé.

Université Paris Cité

Rapport de la Drees en 2022

Une espérance de vie élevée mais qui stagne en 2022 tout en étant inférieure à celle de 2019 : 85,3 ans pour les femmes, 79,4 ans pour les hommes

avec

- La poursuite du vieillissement de la population française avec 16 % de personnes de 75 ans ou plus attendus en 2052, contre 9 % aujourd'hui
- L'importance des troubles dépressifs et du sommeil dans la population
- Des inégalités territoriales et sociales de santé toujours marquées
- Un poids croissant des limitations et de la dépendance

Drees : Direction de la Recherche, des Études, des Evaluations et des Statistiques, Ministère de la Santé et de la Prévention

Université Paris Cité

Les problèmes de santé

Loi relative à la politique de Santé Publique d'août 2004 :

« Le terme de « problème de santé » désigne les maladies qui retentissent sur l'état de santé de la population ainsi que les principaux déterminants associés à la survenue de ces maladies, à leur aggravation ou à l'importance de leur retentissement….

Université Paris Cité

Les problèmes de santé

.... « Cette analyse par pathologie ou par déterminant peut être complétée par une analyse transversale permettant de mettre en évidence les problèmes communs à des groupes de population ainsi que par l'identification de services rendus par le système de santé dont l'amélioration est jugée importante »

Loi relative à la Politique de Santé Publique, 2004.

Université Paris Cité

Les problèmes de santé : une évolution au cours du temps

Les changements de paradigme

1- période hygiéniste : 18ème – 19ème siècle : les miasmes et l'environnement

2- période biomédicale : 19ème – 20ème siècle : la bactérie et l'antibiotique

3- période santé publique : depuis mi 20ème siècle : de la maladie infectieuse à la maladie chronique

Université Paris Cité

1. Période hygiéniste : les miasmes et l'environnement

une grande partie de la baisse de la mortalité infectieuse peut s'expliquer par les mesures d'hygiène publique avant qu'il y ait une compréhension adéquate des causes proximales.

- l'amélioration des conditions de vie, y compris le logement et la nutrition,
- l'amélioration de la qualité de l'eau (John Snow épidémie de choléra à Londres 1840), l'assainissement et l'approvisionnement alimentaire.
- L'introduction du lait pasteurisé et la baisse de la mortalité des maladies diarrhéiques de l'enfance.
- Le lavage des mains et les infections nosocomiales (Semmelweiss)

Université Paris Cité

2. Période biomédicale : la bactérie, l'asepsie et l'antibiotique

1864 Pasteur : les micro-organismes

lien entre la fièvre puerpérale et le vibrion pyogénique dans le sang, et suggère d'utiliser l'acide borique pour tuer ces micro-organismes avant et après l'accouchement : asepsie

1928 Flemming : la pénicilline

observe par hasard la destruction de colonies de *staph dorés* par une moisissure (*penicillium notatum*) *(sérendipité)* mais ne sait pas l'exploiter

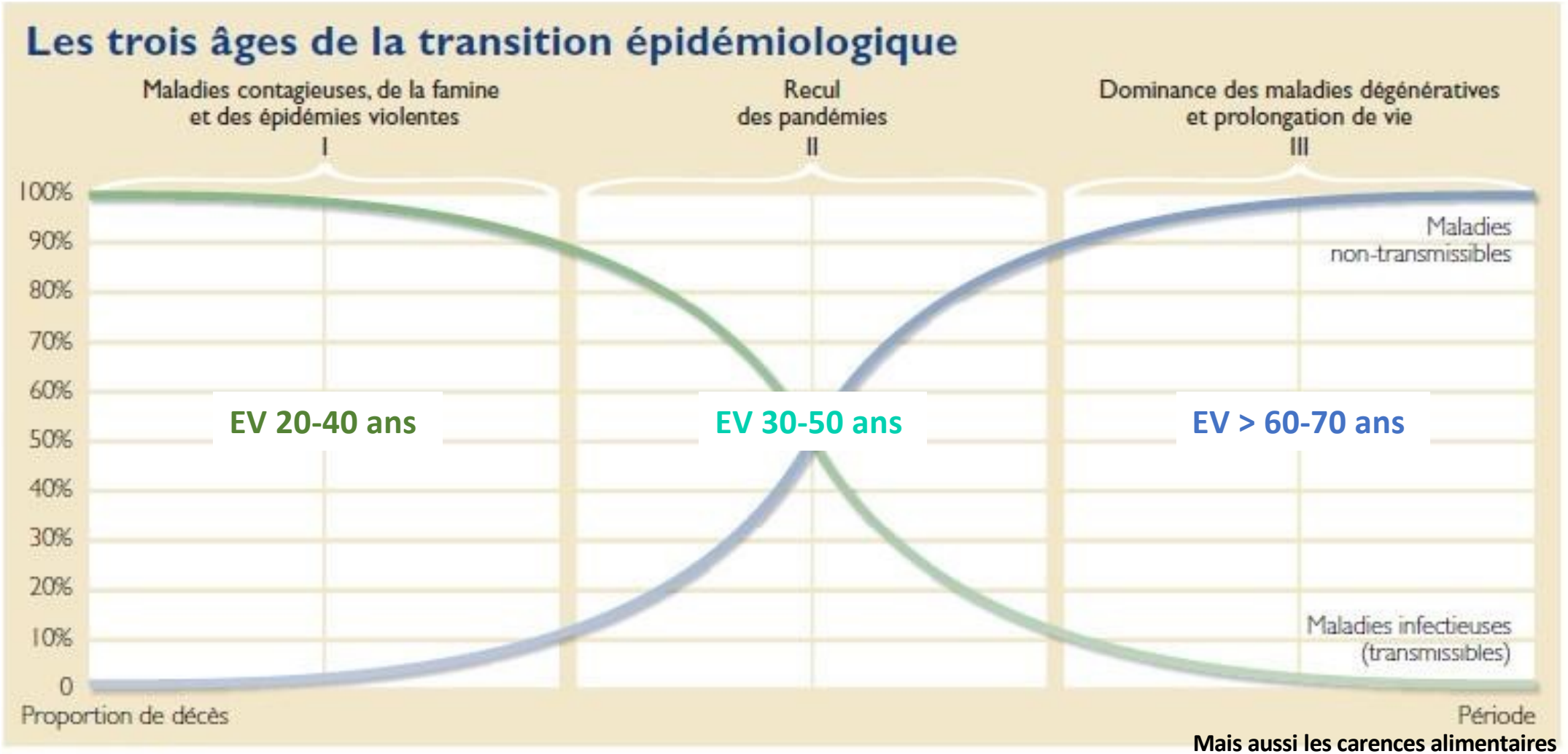
en 1939, Howard Florey, pathologiste australien, Ernst Chain, biochimiste et pathologiste d'origine allemande, et Norman Heatley, biologiste anglais, réussirent à purifier la pénicilline G.

Université Paris Cité

3. Période santé publique : Transition épidémiologique 1940-1960

a) Amélioration de l'hygiène et alimentation : déclin des maladies infectieuses et diminution drastique de la mortalité en particulier la mortalité infantile
b) Amélioration de l'organisation des services de santé : importance relative de la médecine clinique dans l'amélioration de la santé
c) Transition démographique : augmentation de l'espérance de vie et en contrepartie de la population âgée et de l'incidence des maladies chroniques
d) Augmentation des dépenses médicales de santé

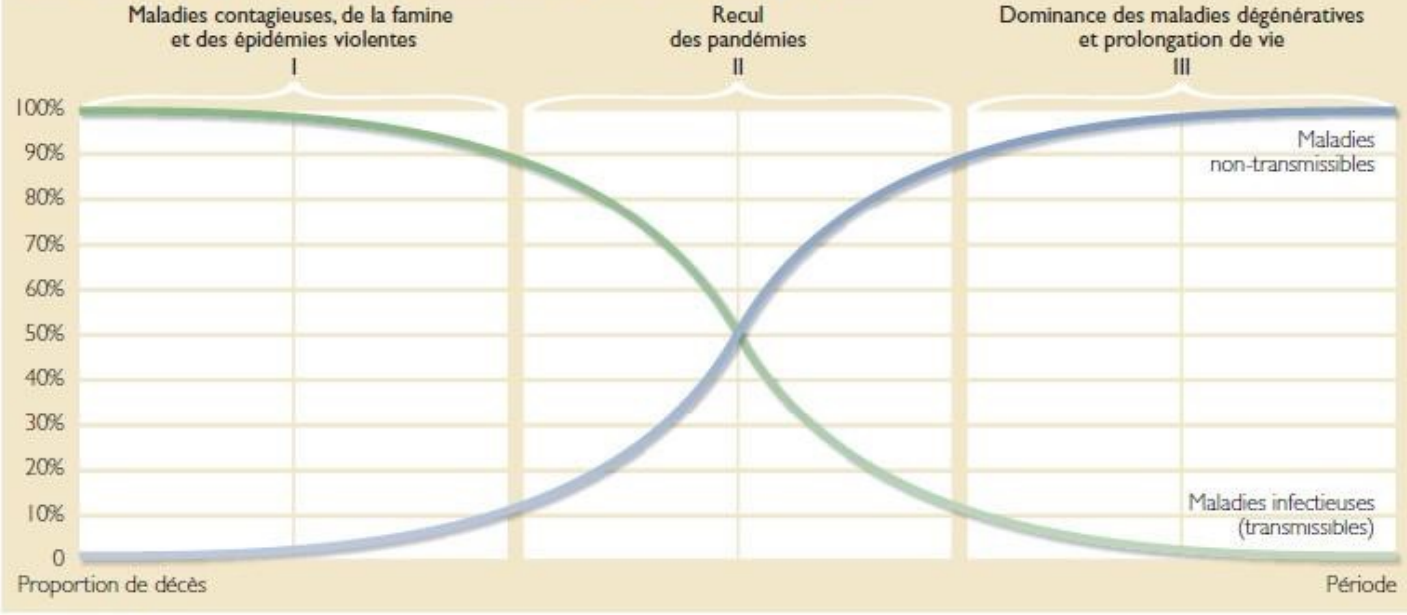
☞ **Transformation des causes de décès depuis les maladies infectieuses vers les maladies chroniques et dégénératives et les accidents.**



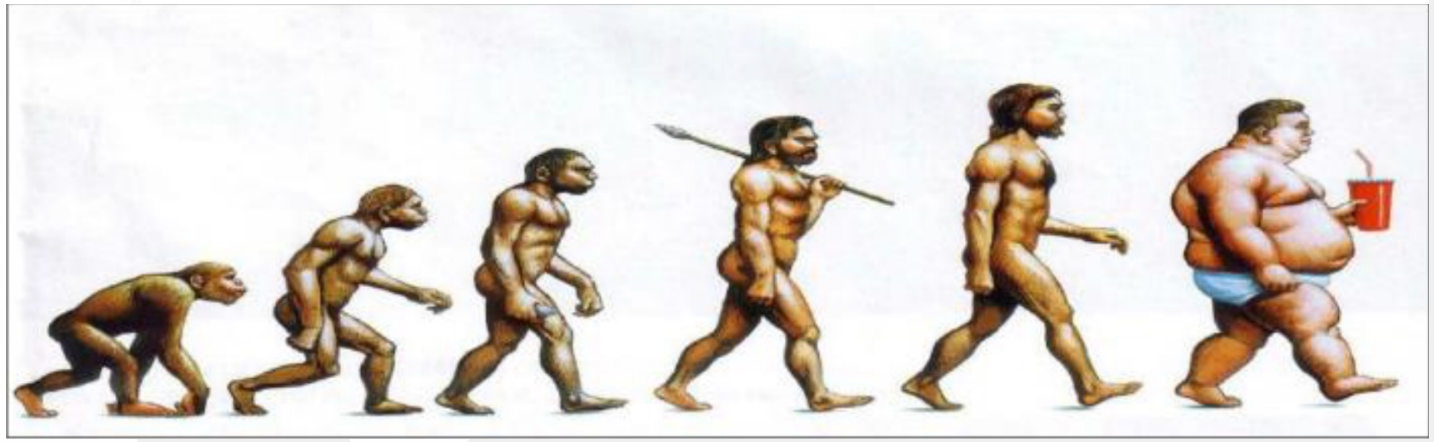
Mais aussi les carences alimentaires

Les 3 cycles d'Omran, 1971

Les trois âges de la transition épidémiologique



Source : Avdeev A. op. cit.



Université Paris Cité

Les grands problèmes de santé

Approche par maladie

Approche par le risque

Université Paris Cité

Les grands problèmes de santé

Approche par maladie

Université Paris Cité

Problématiques de santé, enjeux de santé publique et politique de santé

Critères retenus pour qu'un problème requière une action de santé publique :

1. **ampleur et gravité du problème** : analyser les déterminants et l'impact du problème, morbidité mortalité/létalité (prématuré, évitable), années de vie perdues ajustées sur le handicap, charge affective pour l'entourage, coûts élevés.

   → EPIDEMIOLOGIE, outil d'analyse quantitative

2. **Existence de méthodes efficaces, effectives et acceptables** pour les patients, leurs familles et la société pour traiter le problème

Université Paris Cité

Problème de santé

devient un **problème de santé publique** lorsqu'il remet en cause l'**équilibre de la société** par son importance : cancer, maladies cardio-vasculaires, accidents de la route, crises sanitaires (COVID 19, Ebola, sida, grippe aviaire H5N1).

Université Paris Cité

Le Monde

Exemple : un thème
Le cancer
1ère cause de mortalité

SCIENCES • CANCER

Cancers : leur incidence a doublé en France depuis 1990

Selon les chiffres publiés le 4 juillet par Santé publique France et l'Institut national du cancer, la hausse s'explique d'abord par l'évolution démographique. Les autres causes sont liées aux modes de vie (alcool, tabac, surpoids, etc.) et à l'environnement.

Cancer du sein et cancer colorectal : les Français ne se font pas assez dépister

Selon une étude de Santé publique France, le dépistage du cancer du sein a été affecté par la pandémie de Covid-19. Seulement 50 % des femmes y participent. Et seuls 32 % des Français se font dépister du cancer colorectal.

SANTÉ • CANCER

Cancer du sein : moins d'une femme sur deux participe au dépistage organisé en France

Le niveau de participation a tendance à reculer en France depuis une dizaine d'années. Une étude de Santé publique France pointe notamment un impact persistant de la crise sanitaire liée au Covid.

Le Monde avec AFP
Publié le 02 mai 2024 à 16h42 · Lecture 1 min.

Le cancer devient la première cause de décès dans les pays riches

A l'échelle de la planète, les maladies cardiaques restent les premières responsables, représentant aujourd'hui plus de 40 % des décès.

Le Monde

Publié le 03 septembre 2019 à 16h48 - Mis à jour le 03 septembre 2019 à 16h49 · Lecture 2 min.

Chaque année, plus de 157 000 personnes meurent d'un cancer en France. Au total, 3,8 millions de personnes vivent avec la maladie. Quatre nouveaux cancers sur dix seraient évitables. S

Publié le 04 février 2021 à 08h41 - Mis à jour le 04 février 2021 à 16h00

prévenus, si la population adhérait aux programmes de dépistage organisé, s'alimentait de façon équilibrée, pratiquait une activité physique régulière.

Publié le 13 juin 2023

Cancer du poumon : taux de dépistages positifs beaucoup plus élevé chez les femmes

Deux à trois fois plus de femmes que d'hommes ont été dépistées positivement au cancer du poumon dans l'étude Cascade. Cette maladie pourrait bientôt devenir la première cause de mortalité par cancer devant celui du sein.

Université Paris Cité

Démarche de santé publique

Processus en 4 étapes :

1. **Analyser le problème de santé : Importance du problème de santé**
2. Définir les priorités de santé : qui quand où ?
3. Mettre en place des actions de santé
4. Evaluer les actions entreprises.

Université Paris Cité

1- Analyser le problème de santé : ampleur et gravité du problème

La fréquence (temps lieu personnes) : grand nombre d'individus, fréquence significativement croissante.

La gravité : décès prématuré, mortalité évitable et/ou une incapacité majeure et/ou des souffrances importantes.

L'impact socio-économique : conséquences sociales (rôles sociaux) ou économiques importantes.

La perception sociale : perçu par la population comme essentiel. Risque épidémique.

Université Paris Cité

1- Analyser le problème de santé : ampleur et gravité du problème
☛Les indicateurs

En 2023 :

- 433 136 nouveaux cas : 245 610 hommes (57%) et 187 526 femmes (43%)
- **173 000 nouveaux cas pourraient être prévenus, soit 40%**
- Plus de 3,8 millions de personnes vivent avec la maladie
- 162 500 décès par cancer en 2021 : 91 000 hommes (56% ; **1ère cause**) et 71 500 femmes (44% ; **1ère cause**)

Université Paris Cité

Démarche de santé publique

Processus en 4 étapes :

1. Analyser le problème de santé : Importance du problème de santé
2. **Définir les priorités de santé : qui quand où ?**
3. Mettre en place des actions de santé
4. Evaluer les actions entreprises.

Université Paris Cité

Epidémiologie descriptive

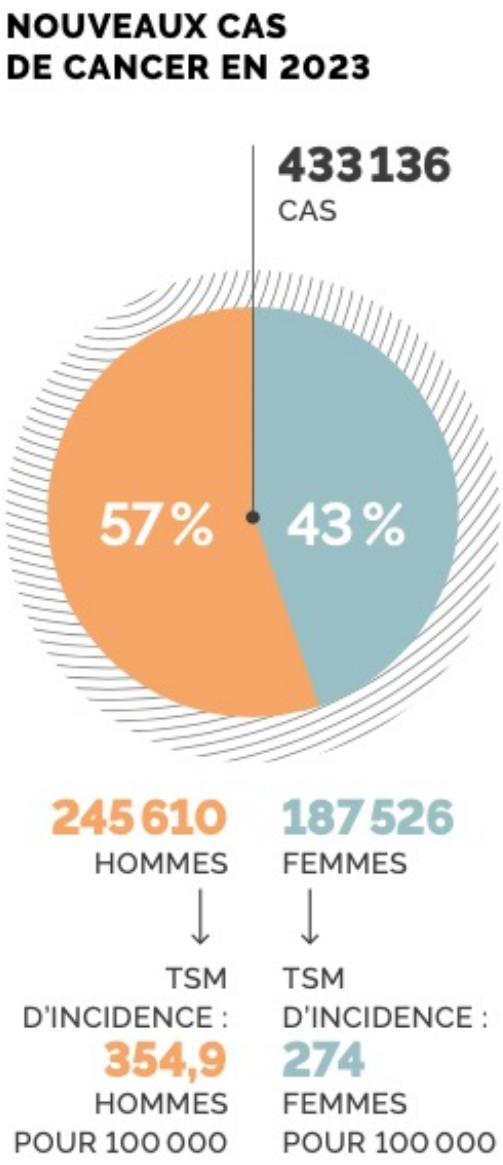
Objectif : décrire la morbidité et la mortalité selon

- Le temps
- Le lieu
- Les personnes
- Les circonstances

Afin de définir des périodes, des zones et des groupes à risque

Université Paris Cité

2023



Université Paris Cité

Taux d'incidences du cancer

Evolution du TSM entre 1990 et 2023

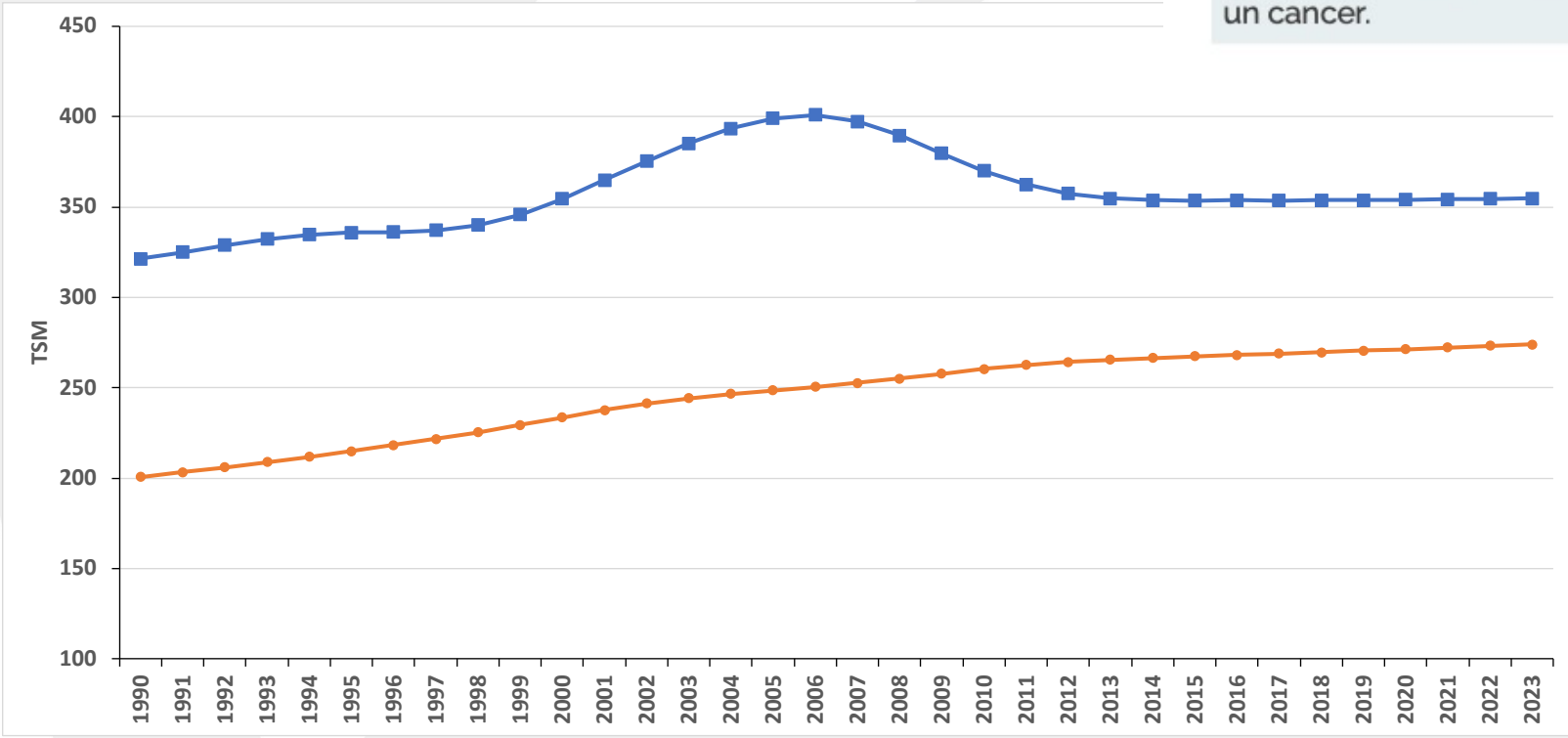
ÉVOLUTION ANNUELLE DU TSM

+0,3 % CHEZ LES HOMMES

+0,9 % CHEZ LES FEMMES

TSM : taux standardisé monde, ou proportion de personnes qui développent un cancer.

Hommes
Femmes



Université Paris Cité

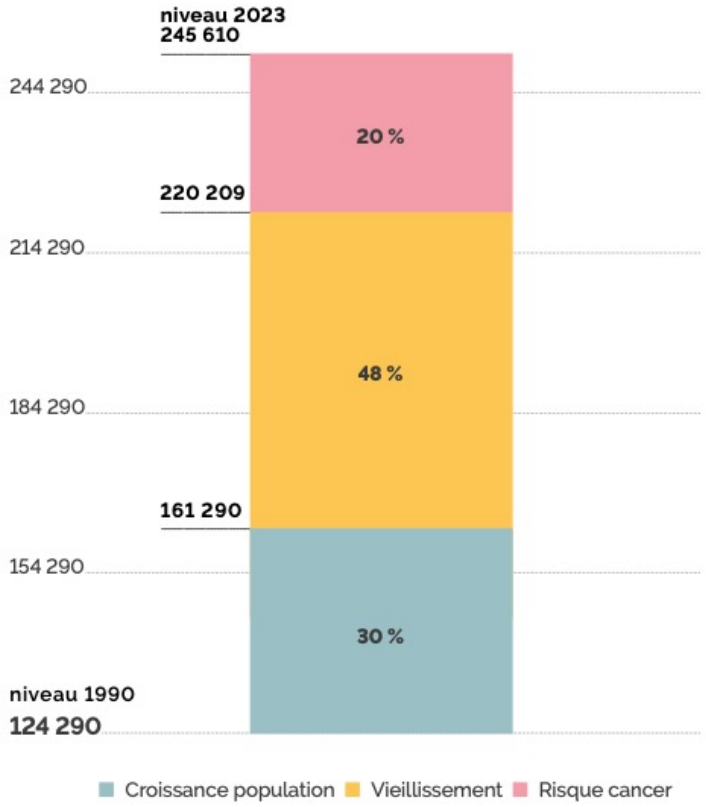
Evolution de l'incidence du cancer entre 1990 et 2023

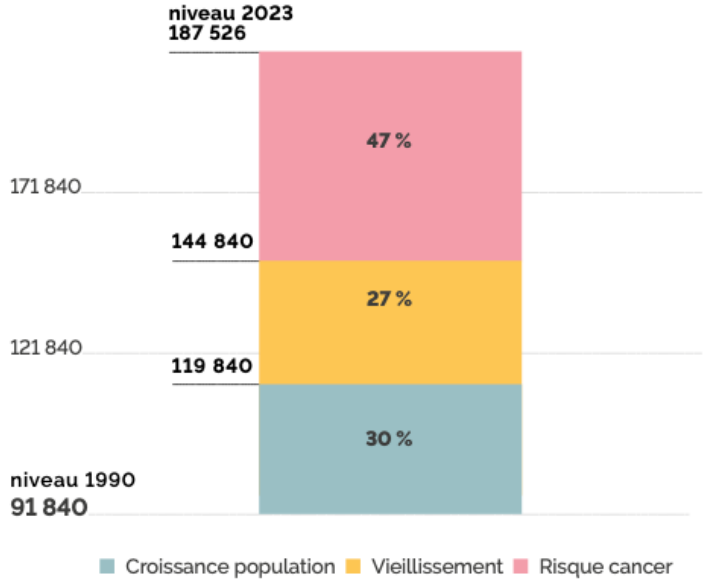
- Entre 1990 et 2023, **le nombre de nouveaux cas de cancers** a doublé, avec une augmentation de 98 % des cancers chez l'homme et de 104 % chez la femme, toutes localisations confondues.

- Cette augmentation est principalement liée **à des évolutions démographiques** (en taille et en structure) et secondairement à une augmentation du risque de cancer.

Université Paris Cité

Décomposition de l'augmentation du nombre de cancers entre 1990 et 2023



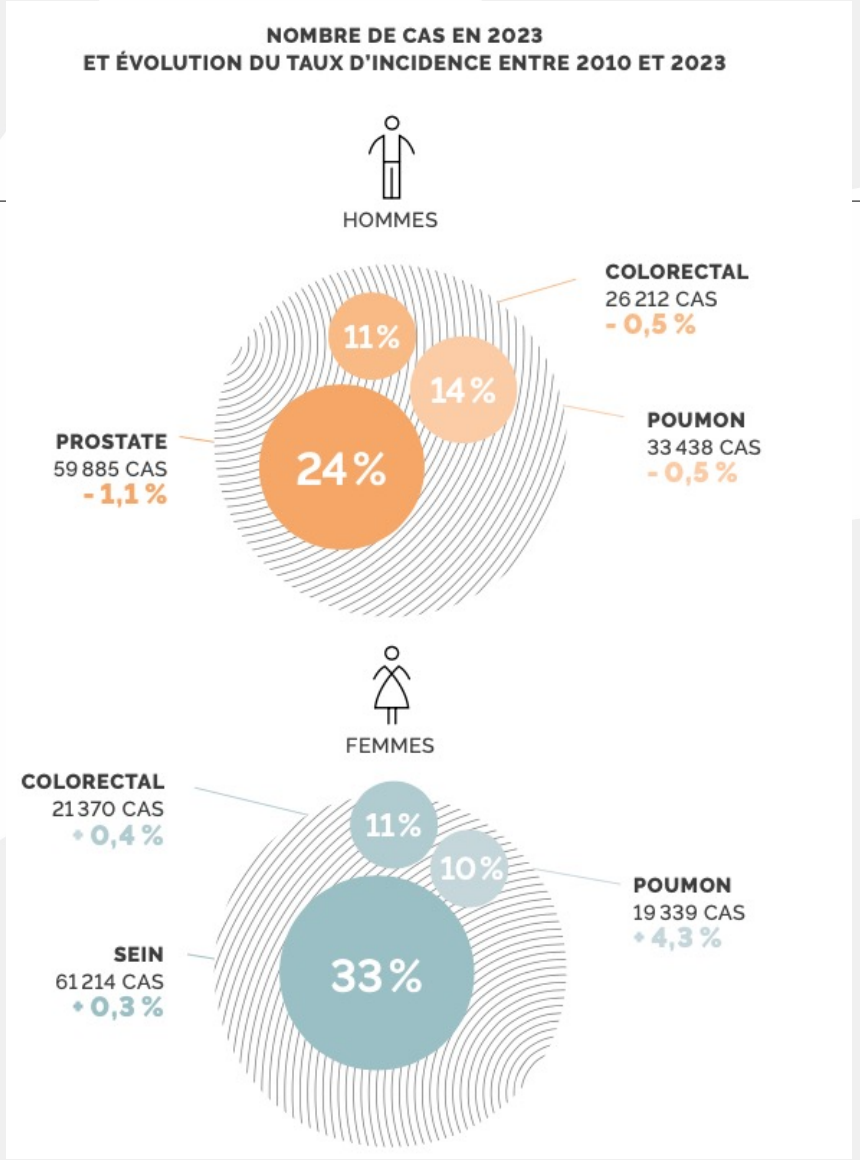


Hommes : augmentation de 98%

Femmes : augmentation de 104%

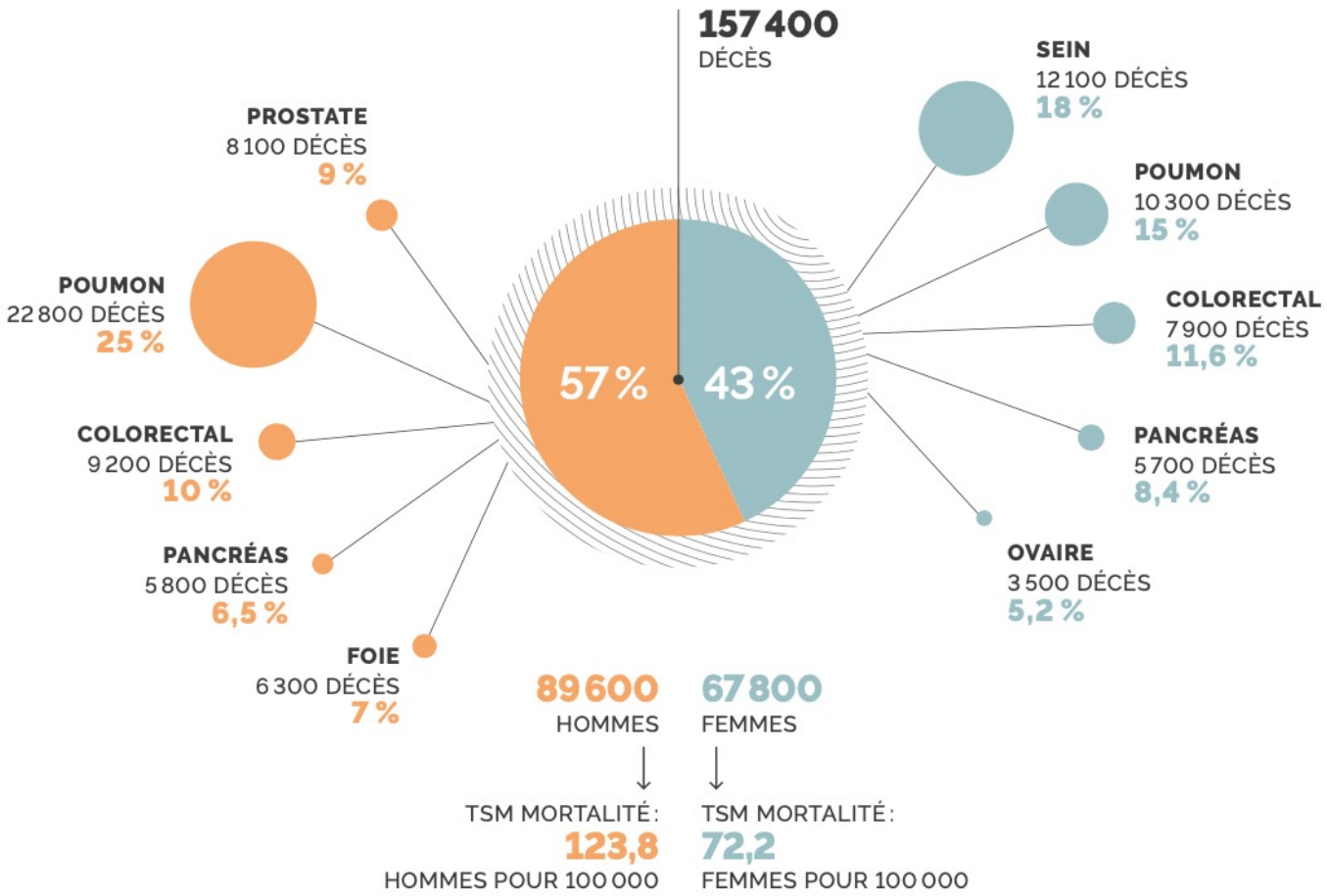
Université Paris Cité

Les 3 principaux cancers selon le sexe



Université Paris Cité

La mortalité liée au cancer



Entre 2010 et 2018

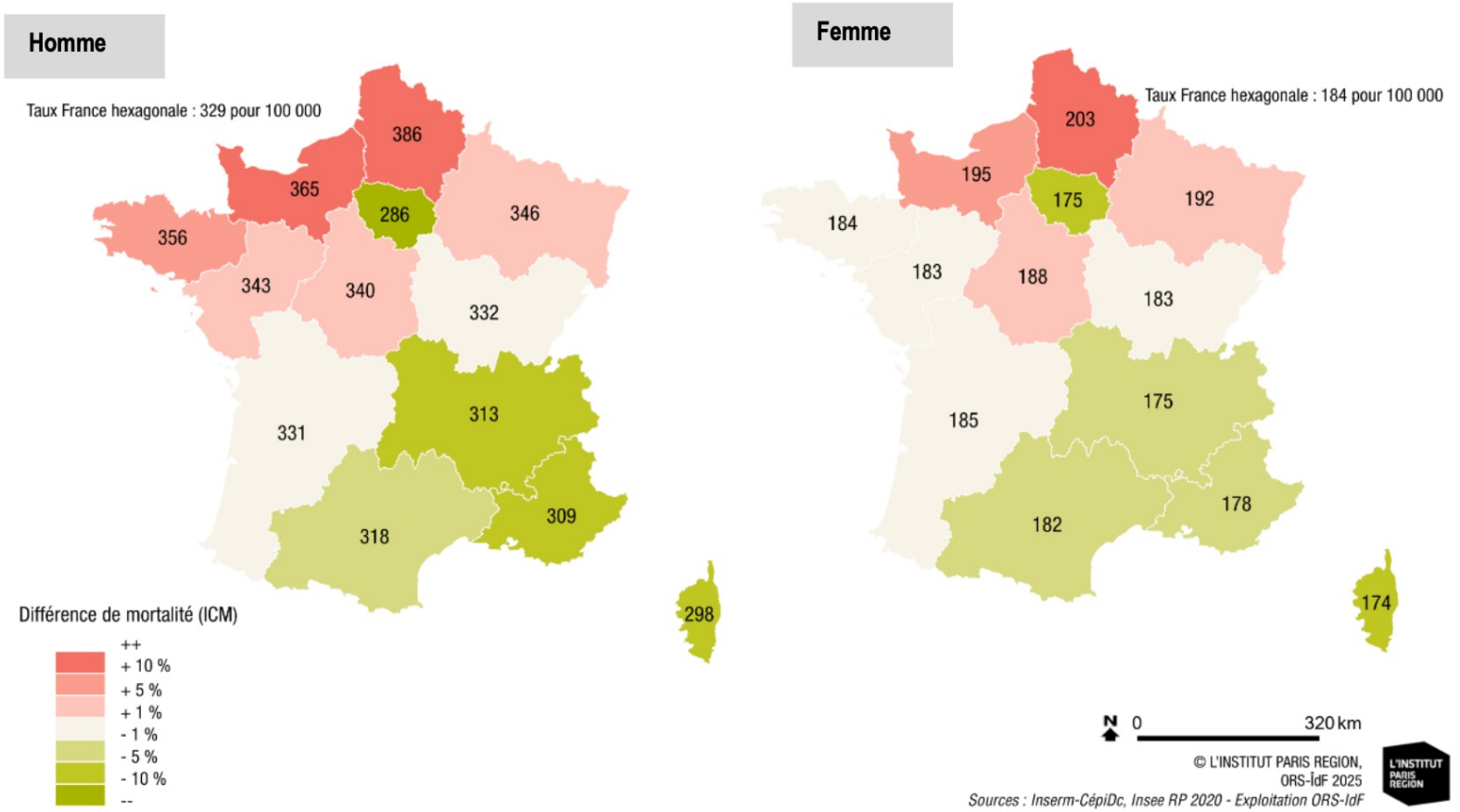
Le TSM de mortalité a diminué de :

- **-2 %** PAR AN CHEZ LES HOMMES
- **-0,7 %** PAR AN CHEZ LES FEMMES

Université Paris Cité

Inégalités territoriales

Carte 1. Taux standardisés de mortalité par cancer par région et écart à la valeur nationale (2018-2022)

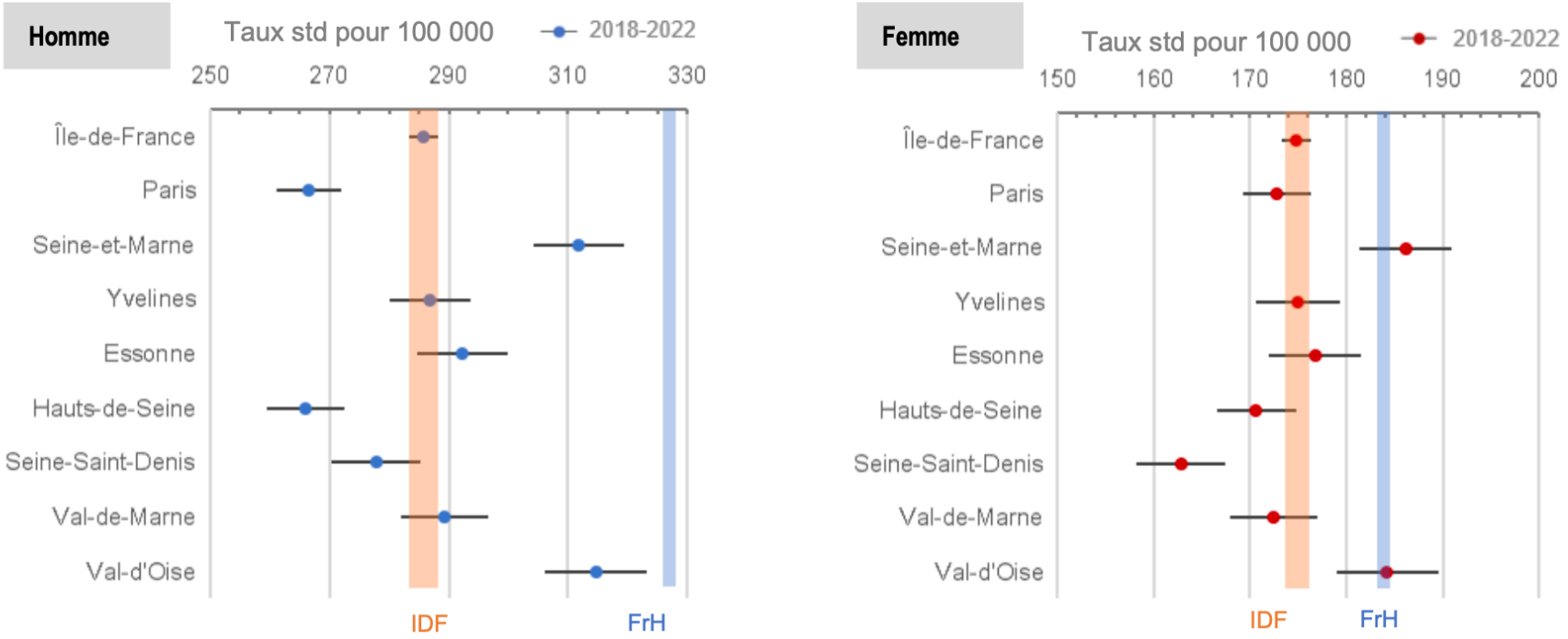


Université Paris Cité

Inégalités territoriales

Figure 4. Taux standardisés de mortalité par cancer par département en 2018-2022

IC = intervalle de confiance à 95 %

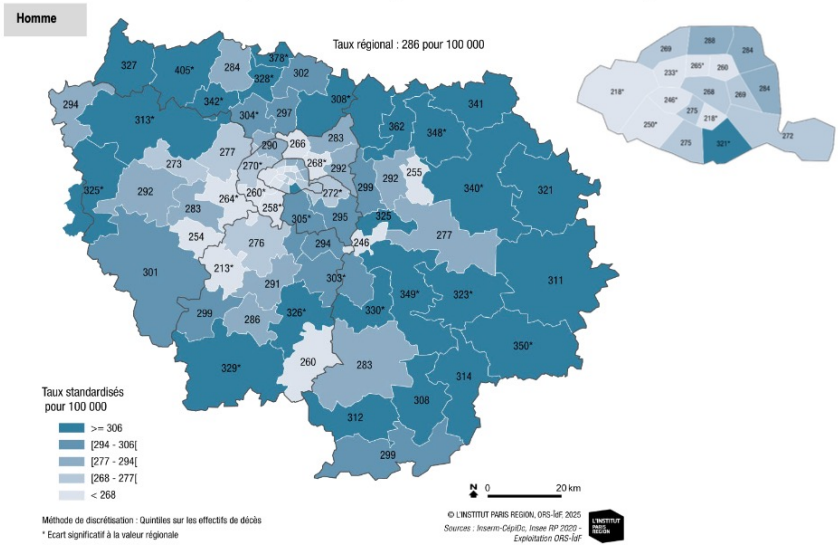


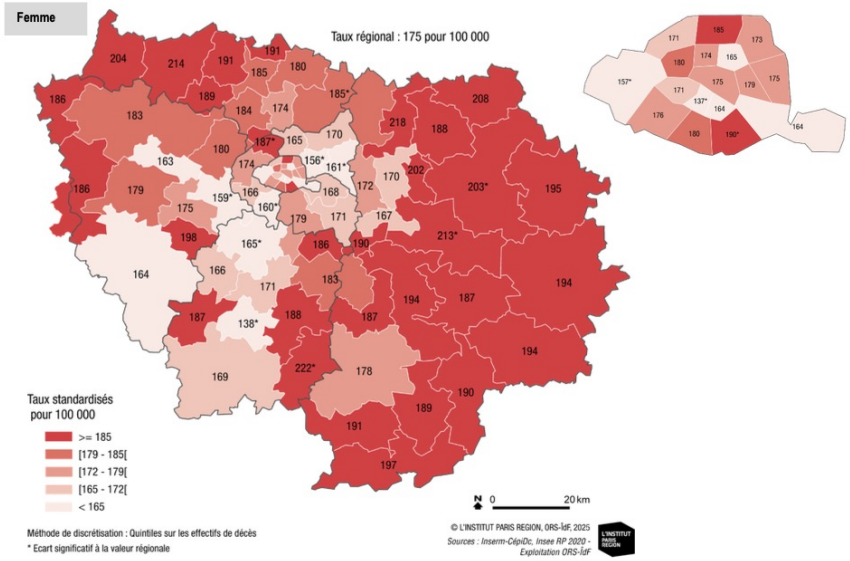
Note de lecture : 267 décès par cancer pour 100 000 hommes ont été enregistrés à Paris en moyenne annuelle sur la période 2018-2022, taux significativement inférieur à celui de la région de 286 pour 100 000. IC à 95 %.

Source : Inserm CépiDc, standardisation France RP2020. Exploitation ORS Île-de-France.

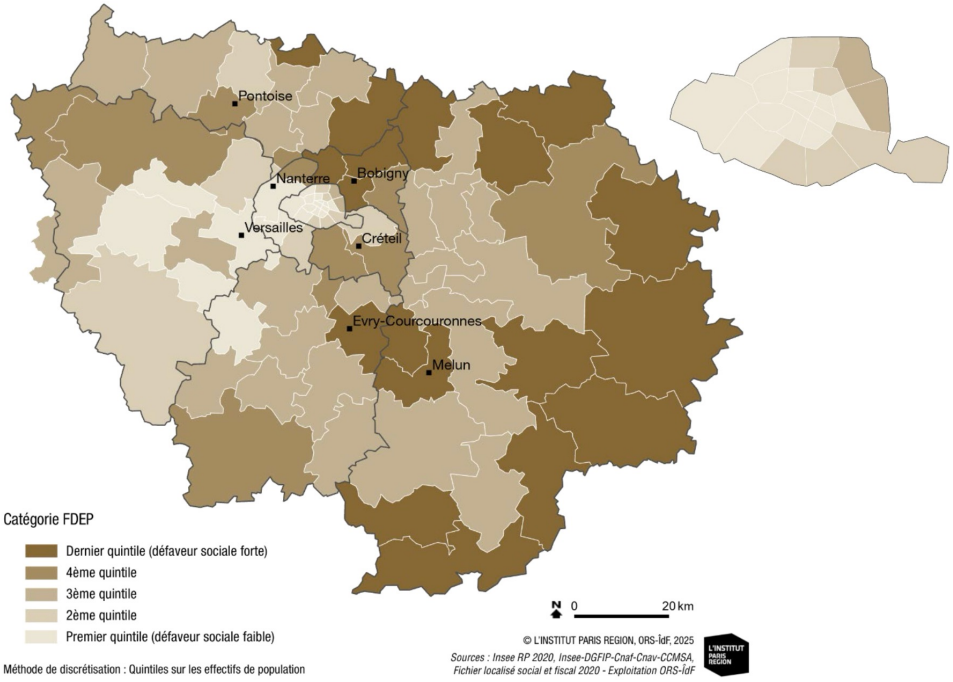
Disparités infra-départementales

Carte 2. Taux standardisés de mortalité par cancer en 2018-2022 par intercommunalités et arrondissements parisiens





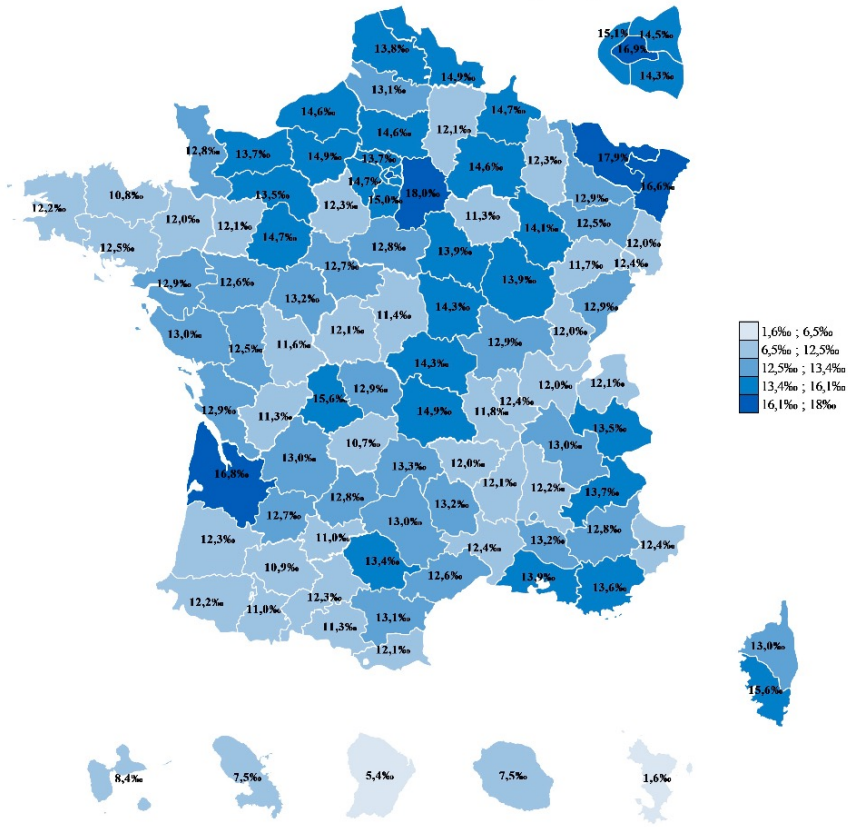
Carte 3. Indice de défaveur sociale en 2020 par intercommunalités et arrondissements parisiens



Université Paris Cité

Inégalités territoriales

Prévalences standardisées des femmes prises en charge pour cancer du sein de la femme sous surveillance par département en 2023



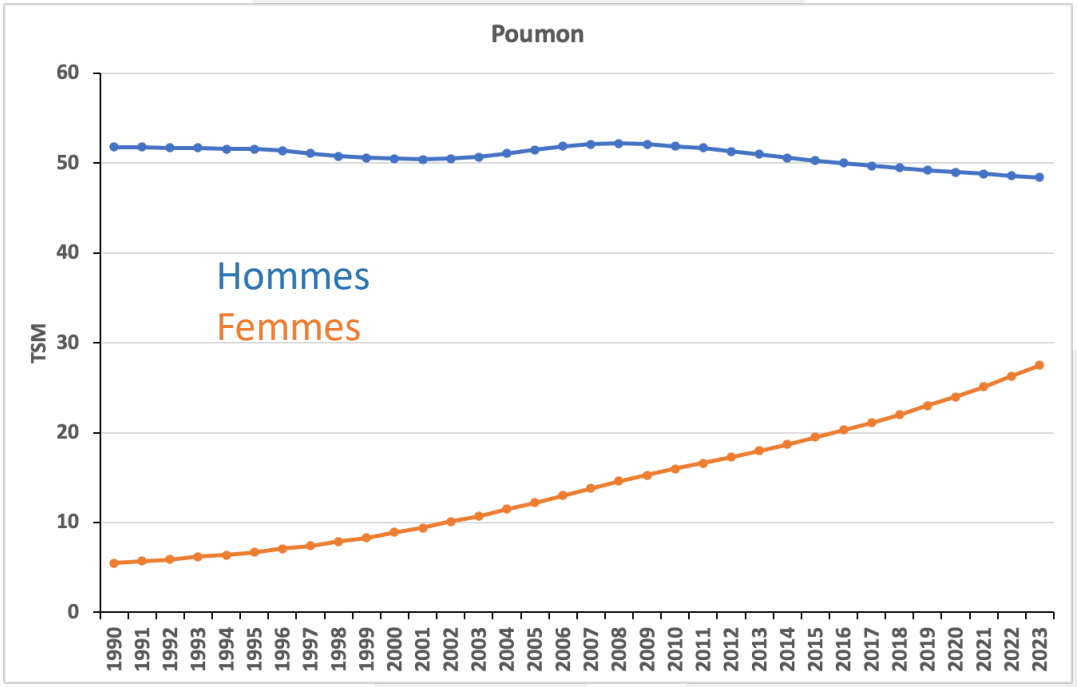
Champ : tous régimes, dépenses remboursées - France entière
Source : Cnam (cartographie version de juillet 2025)
Méthode : standardisation sur la structure d'âge et de sexe de la population Insee

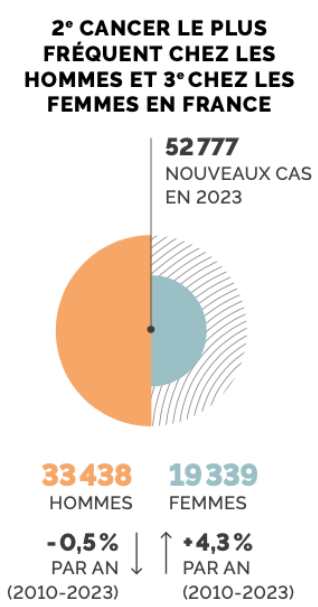
Université Paris Cité

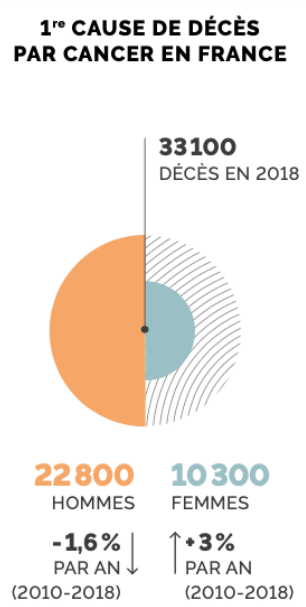
Taux d'incidence : cancer du poumon/bronchopulmonaire

Evolution du TSM entre 1990 et 2023

1er FDR : le TABAC





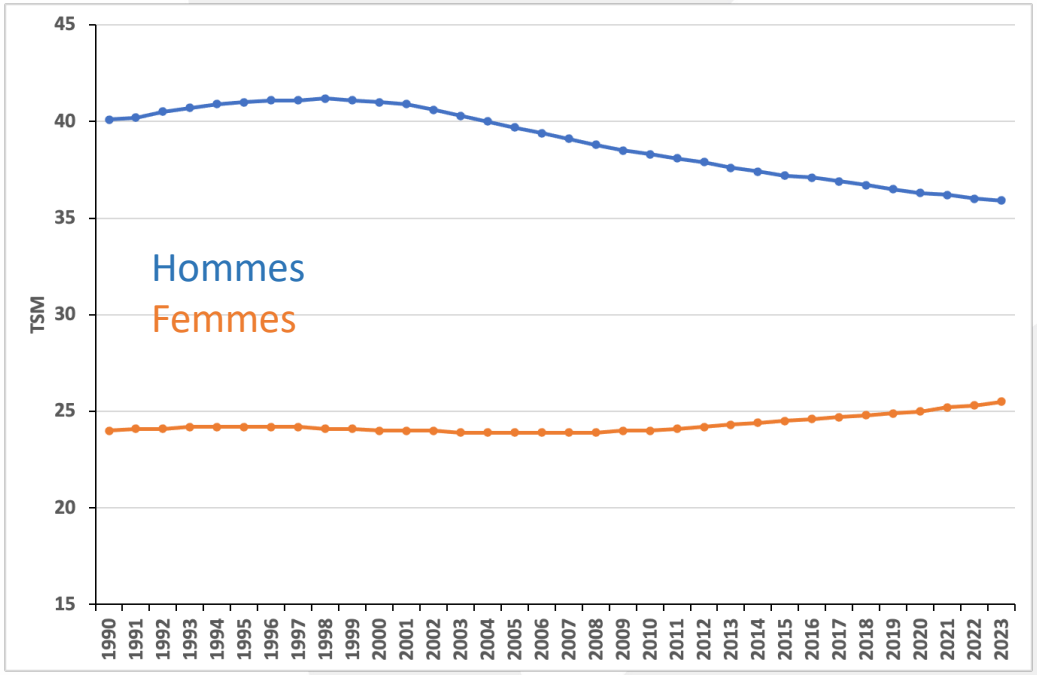


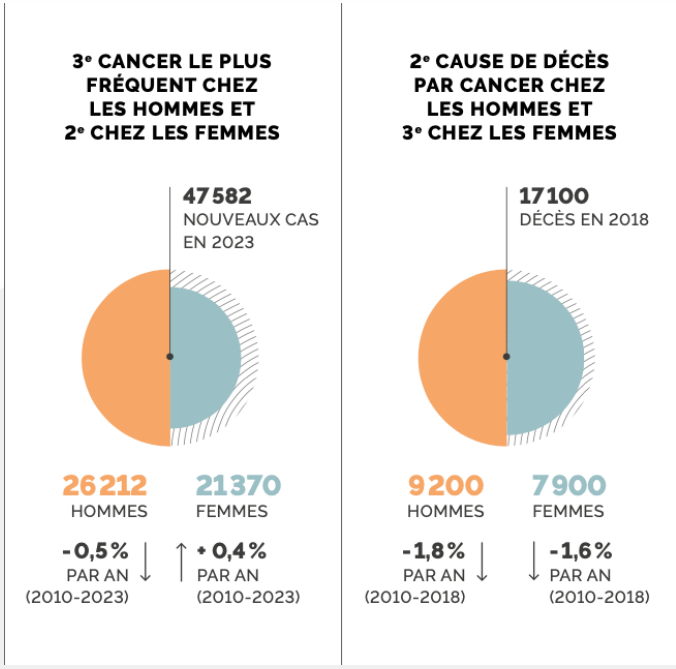
Université Paris Cité

Taux d'incidence : cancer colorectal

Evolution du TSM entre 1990 et 2023

1ers FDR : alcool, alimentation déséquilibrée, sédentarité, surpoids/obésité



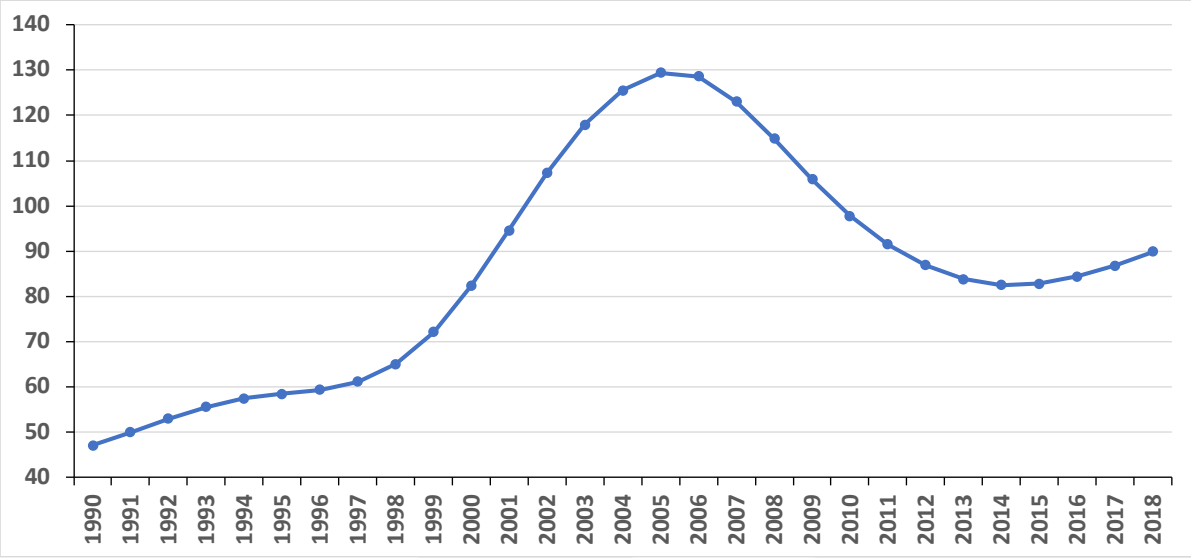


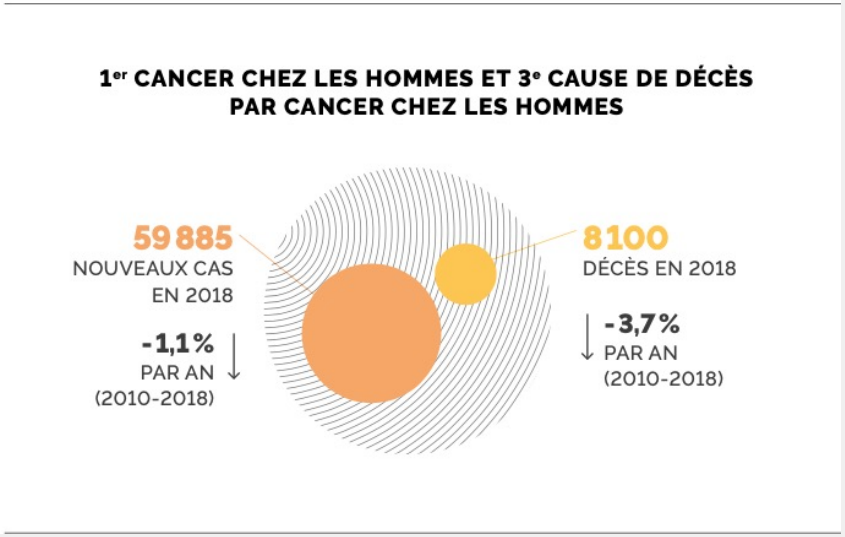
Université Paris Cité

Taux d'incidence : cancer de la prostate

Evolution du TSM entre 1990 et 2023

1er FDR : génétiques



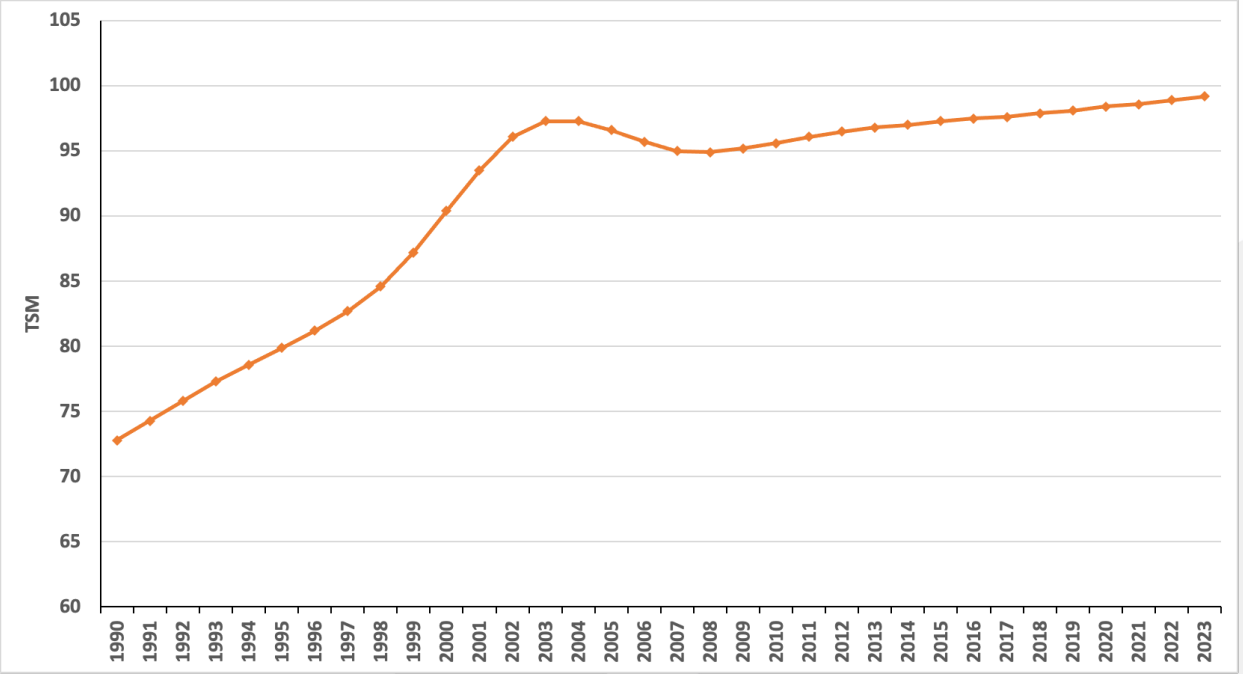


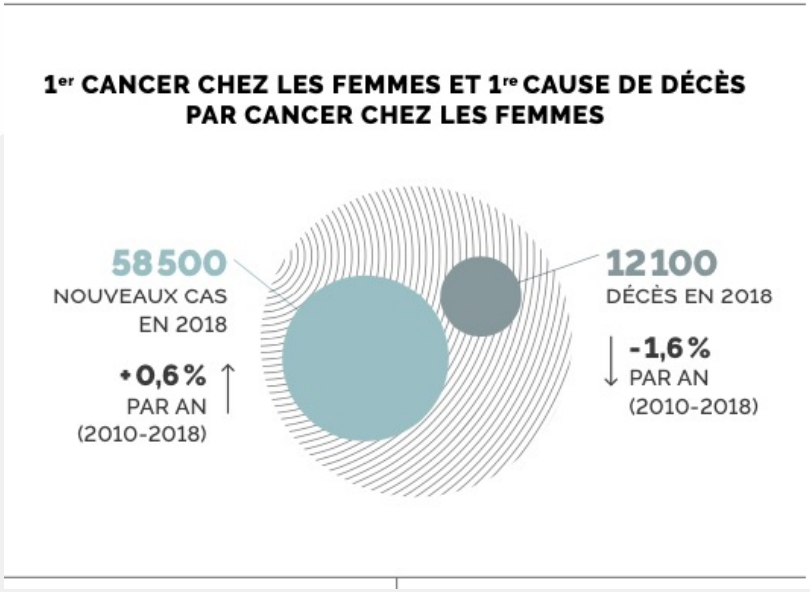
Université Paris Cité

Taux d'incidence : cancer du sein

Evolution du TSM entre 1990 et 2023

1ers FDR : âge, ATCD familiaux, alcool, surpoids/obésité



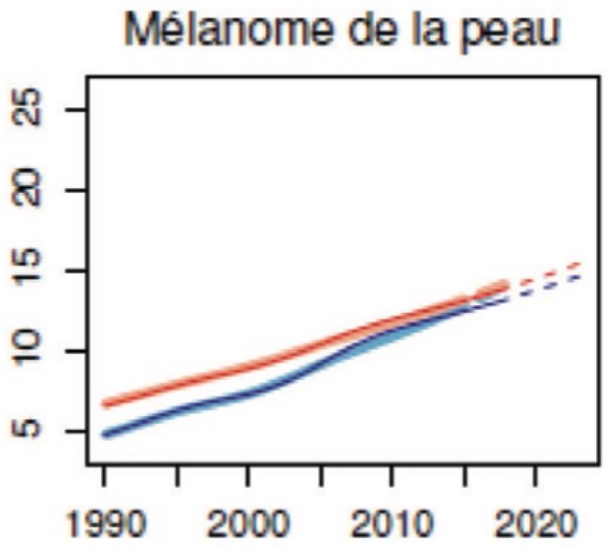


Université Paris Cité

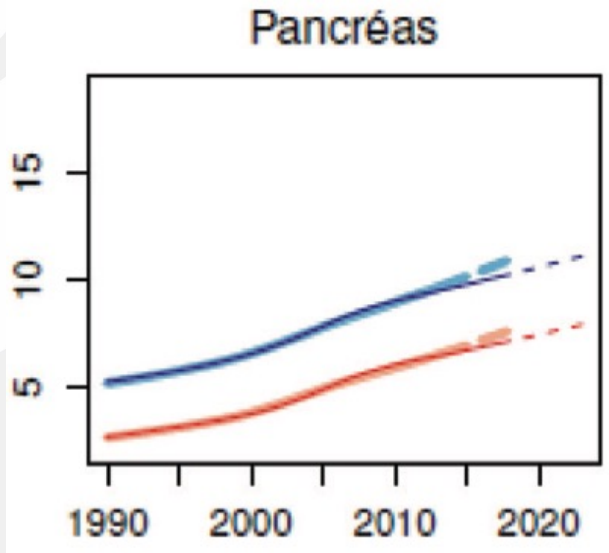
Attention !

Evolution du TSM entre 1990 et 2023

1ers FDR : exposition au soleil, UV



1ers FDR : tabac, surpoids/obésité



1990 - 2023

+ 3,5 % par an

+ 2,3 % par an

Homme

Étude 1990-2018 — Étude 1990-2023

Femme

Étude 1990-2018 — Étude 1990-2023

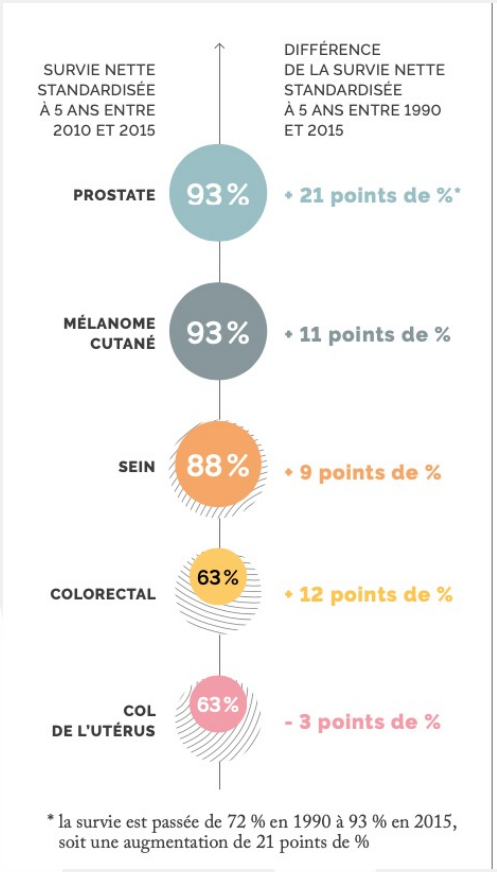
+ 2,6 % par an

+ 3,3 % par an

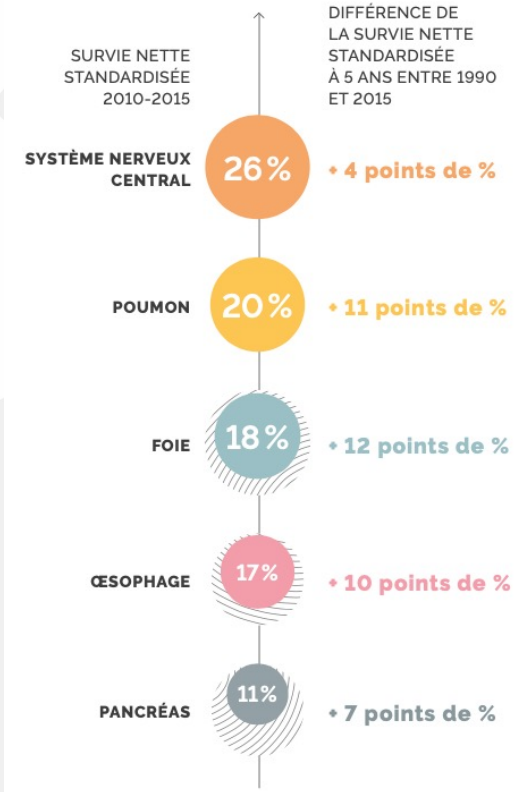
Université Paris Cité

Pronostic des cancers

Les bons



Les mauvais



Université Paris Cité

En résumé

- L'incidence du cancer augmente annuellement depuis 1990, moins fortement chez les hommes que chez les femmes.

- La mortalité par cancer diminue depuis 30 ans mais cette diminution est plus importante chez les hommes que chez les femmes. Le cancer reste la première cause de mortalité en France.

- Chez les femmes, les 3 principales localisations de cancer sont le sein, le colon, le poumon et les 3 principales causes de mortalité par cancer sont le sein, le poumon, le colon. L'incidence et la mortalité par cancer du poumon augmentent.

- Chez les hommes, les 3 principales localisations de cancer sont la prostate, le poumon, le colon et les 3 principales causes de mortalité par cancer sont le poumon, le colon, la prostate.

- On décrit de fortes inégalités territoriales et de sexe en termes d'incidence et mortalité par cancer.

Université Paris Cité

Démarche de santé publique

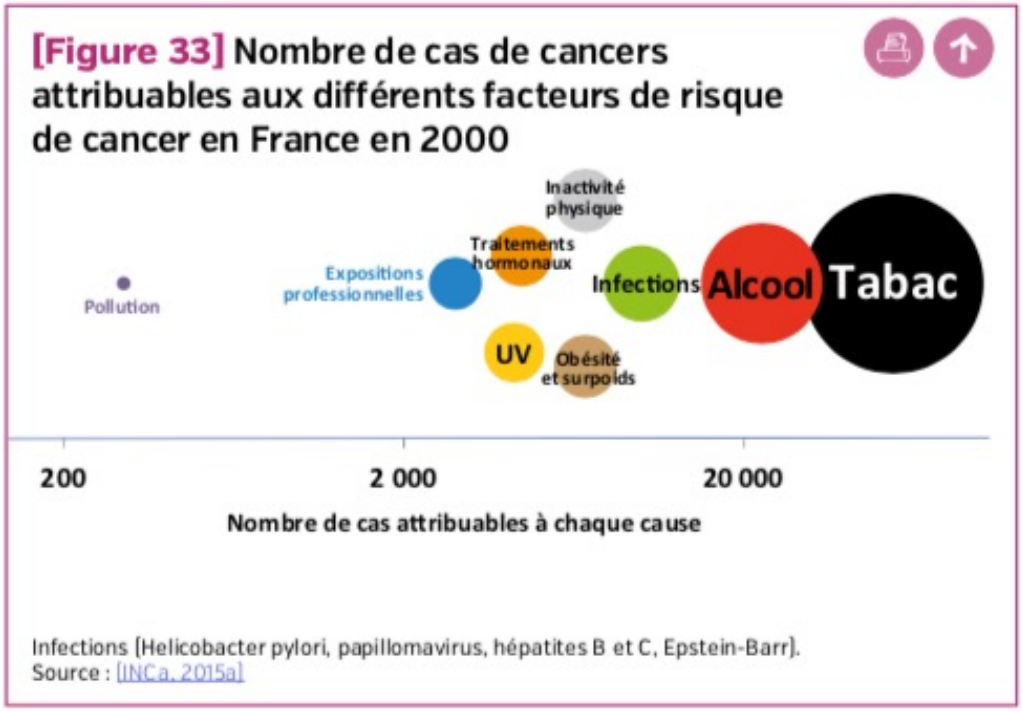
Processus en 4 étapes :

1. Analyser le problème de santé : Importance du problème de santé
2. Définir les priorités de santé : qui quand où ?
3. **Mettre en place des actions de santé**
4. Evaluer les actions entreprises.

Université Paris Cité

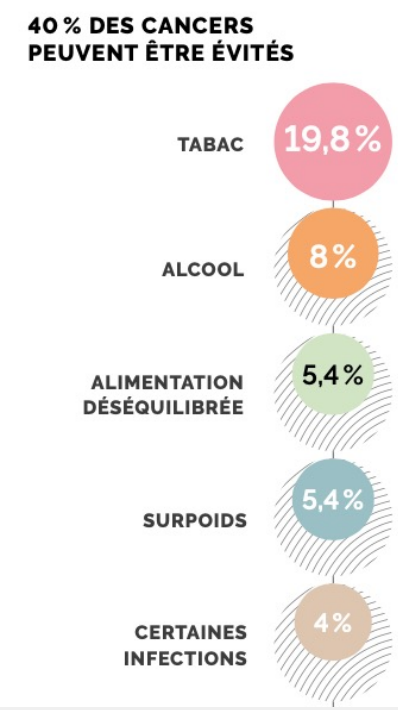
Actions de santé publique

Causes et déterminants du problème de santé





En 2023



Université Paris Cité

Actions de santé publique

Recommandations nationales

- **Plan nationaux :**
  - Plan Cancer : 2003-2007; 2009-2013; 2014-2019; 2021-2030 (stratégie décennale)
  - Tabac : PNRT Plan National de Réduction du Tabagisme 2014 ; PNLT Plan National de Lutte contre le Tabac 2018-2022
  - Alcool : ?
  - Nutrition : PNNS 4 Plan National Nutrition Santé 2019-2023, reco pour le PNNS 5
  - Environnement : PNSE 4 Plan National Santé Environnement
  - ...
- **Dépistages organisés :** mammographie, frottis cervico-vaginaux , consultation dermatologique, test de dépistage immunologique pour le cancer colo-rectal ...
- **Investissement dans la Recherche en prévention primaire**

Université Paris Cité

Démarche de santé publique

Processus en 4 étapes :

1. Analyser le problème de santé : Importance du problème de santé
2. Définir les priorités de santé : qui quand où ?
3. Mettre en place des actions de santé
4. **Evaluer les actions entreprises.**

Université Paris Cité

Quels sont les impacts ?

Globalement, la mortalité liée au cancer a diminué mais cela reste la première cause de mortalité avec 40% des cas pouvant être prévenus par la modification de nos comportements.

GOUVERNEMENT
Liberté
Égalité
Fraternité

COMMUNIQUE DE PRESSE

Paris, le 04 février 2021

La France se dote pour la première fois d'une stratégie de lutte contre les cancers sur dix ans

Pour la première fois, 4 objectifs chiffrés viennent donner la force de cette ambition :

- **réduire de 60 000 par an le nombre de cancers évitables** à horizon 2040 (le nombre de cancers évitables est aujourd'hui estimé à environ 153 000 par an) ;
- **dépister un million de personnes en plus par an** à partir de 2025 (9 millions de dépistages sont réalisés chaque année) ;
- **réduire de 2/3 à 1/3 la part des patients souffrant de séquelles** 5 ans après un diagnostic ;
- **infléchir significativement le rythme de progression du taux de survie des cancers de plus mauvais pronostic,** à horizon 2030.

Pour y répondre, la stratégie décennale de lutte contre les cancers s'est définie 4 axes stratégiques.

1- Améliorer la prévention, primaire comme secondaire,
2- Limiter les séquelles et améliorer la qualité de vie des patients,
3- Lutter contre les cancers de mauvais pronostic chez l'adulte et chez l'enfant,
4- S'assurer que les progrès en matière de lutte contre les cancers bénéficient à tous.

Université Paris Cité

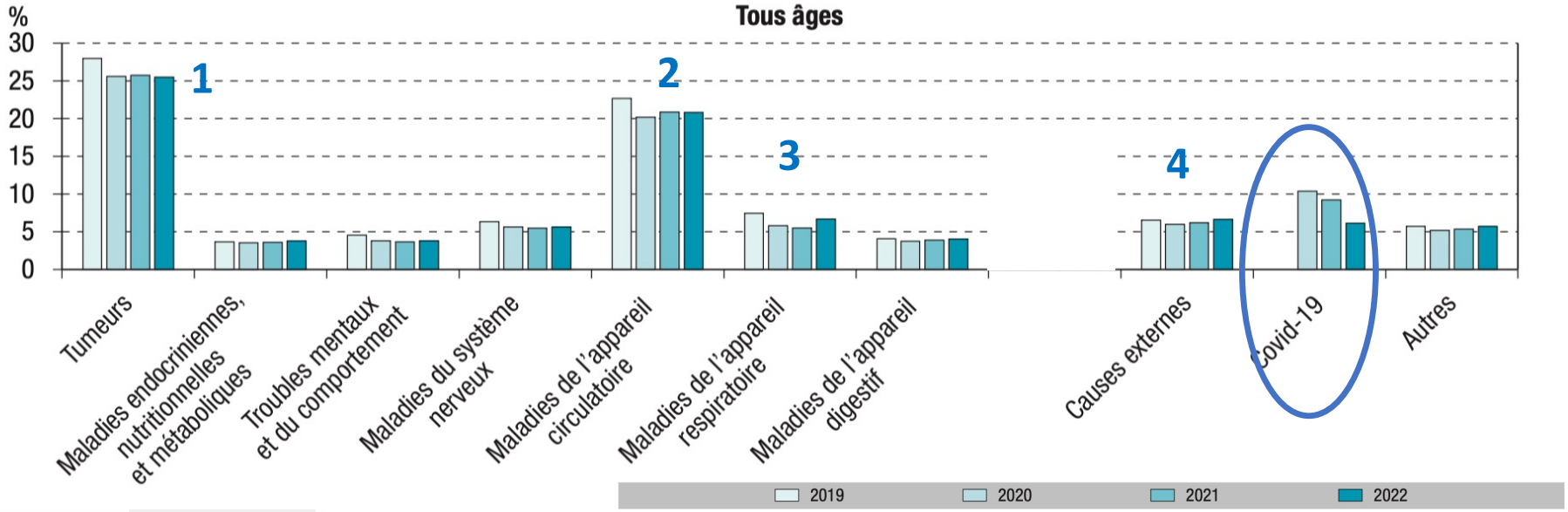
Quels sont les problèmes prioritaires ? Comment les hiérarchiser ?

Université Paris Cité

Quels sont les problèmes prioritaires ? Comment les hiérarchiser ?

Figure 1

Proportion de décès par grande cause parmi les décès toutes causes confondues, tous âges et par classe d'âges, France métropolitaine et DROM, 2019-2022



8 octobre 2024 | BEH 18

Note de lecture : en 2022, 25,5% des décès sont dus à des tumeurs.
Seuls les chapitres de la Classification internationale des maladies (CIM) concernant au moins 2% des décès dans la catégorie d'âge considérée sont représentés.

Université Paris Cité

Quels sont les problèmes prioritaires ? Comment les hiérarchiser ?

Causes de Mortalité les plus fréquentes par ordre décroissant en 2022

- Tumeurs (*1e cause depuis 2004*)
- Maladies cardio-neurovasculaires
- Maladies de l'appareil respiratoire
- Causes externes

Source: *INSERM-CépiDC*

Université Paris Cité

Le fardeau de la mortalité prématurée (65 ans) et évitable

Mortalité prématurée : 20% des décès

Mortalité évitable : 1/3 de la mortalité prématurée

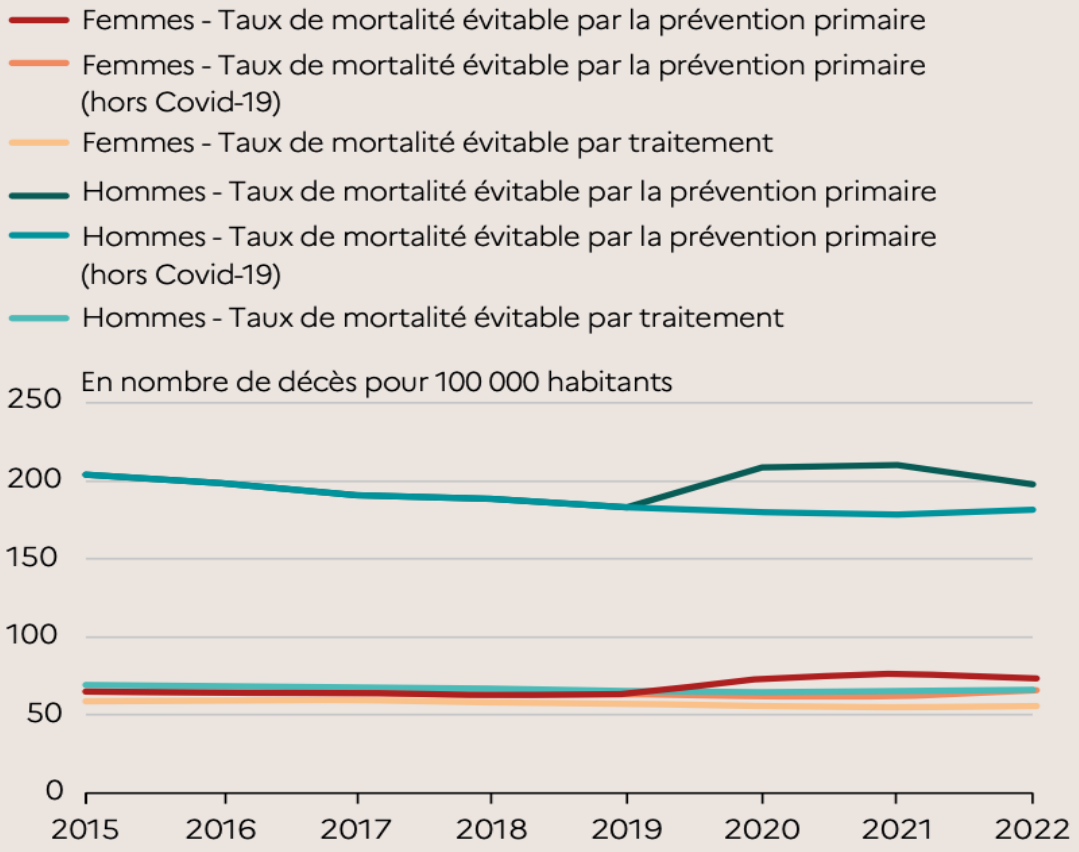
Sexe ratio 3 H : 1F

Cancers 40%
Morts violentes 14%
Appareil cardio-circulatoire 12%

Université Paris Cité

Le fardeau de la mortalité prématurée et évitable

Graphique 3 Évolution de la mortalité évitable, de 2015 à 2022



Lecture > En 2022, 72,8 décès de femmes pour 100 000 habitantes auraient pu être évités par la prévention primaire.
Champ > Personnes décédées en France et résidant en France.
Source > Inserm-CépiDc.

> *Études et Résultats* n° 1312 © DREES

Université Paris Cité

Quels problèmes prioritaires ? Comment les hiérarchiser ?

Principales causes de morbidité en population générale :

Variables selon les tranches d'âge et le sexe

Morbidité ressentie

Problèmes oculaires

Problèmes des articulations

Maladies cardio-vasculaires

Maladies endocriniennes et métaboliques (obésité)

Source : Enquête ESPS, 2010; cité dans
L'état de Santé de la Population en France - Rapport 2015, DREES

Université Paris Cité

Quels problèmes prioritaires ? Comment les hiérarchiser ?

Principales causes d'admission en ALD *(Affection de Longue Durée de l'Assurance Maladie)*

≈ **Les maladies chroniques en France**

- Les maladies cardiovasculaires
- Les tumeurs
- Le diabète
- Les pathologies psychiatriques

Source : statistiques de l'Assurance Maladie

Université Paris Cité

Fardeau social et économique

"Les maladies chroniques concernent aujourd'hui **plus de 20 millions de personnes** en France. Conséquence du **vieillissement de la population**, du développement **des expositions aux pollutions**, ou encore de **certains comportements**, leur progression est constante et toutes les projections confirment qu'elles continueront de toucher un nombre croissant de Français et Française à l'avenir", rappelle le CESE en 2019.

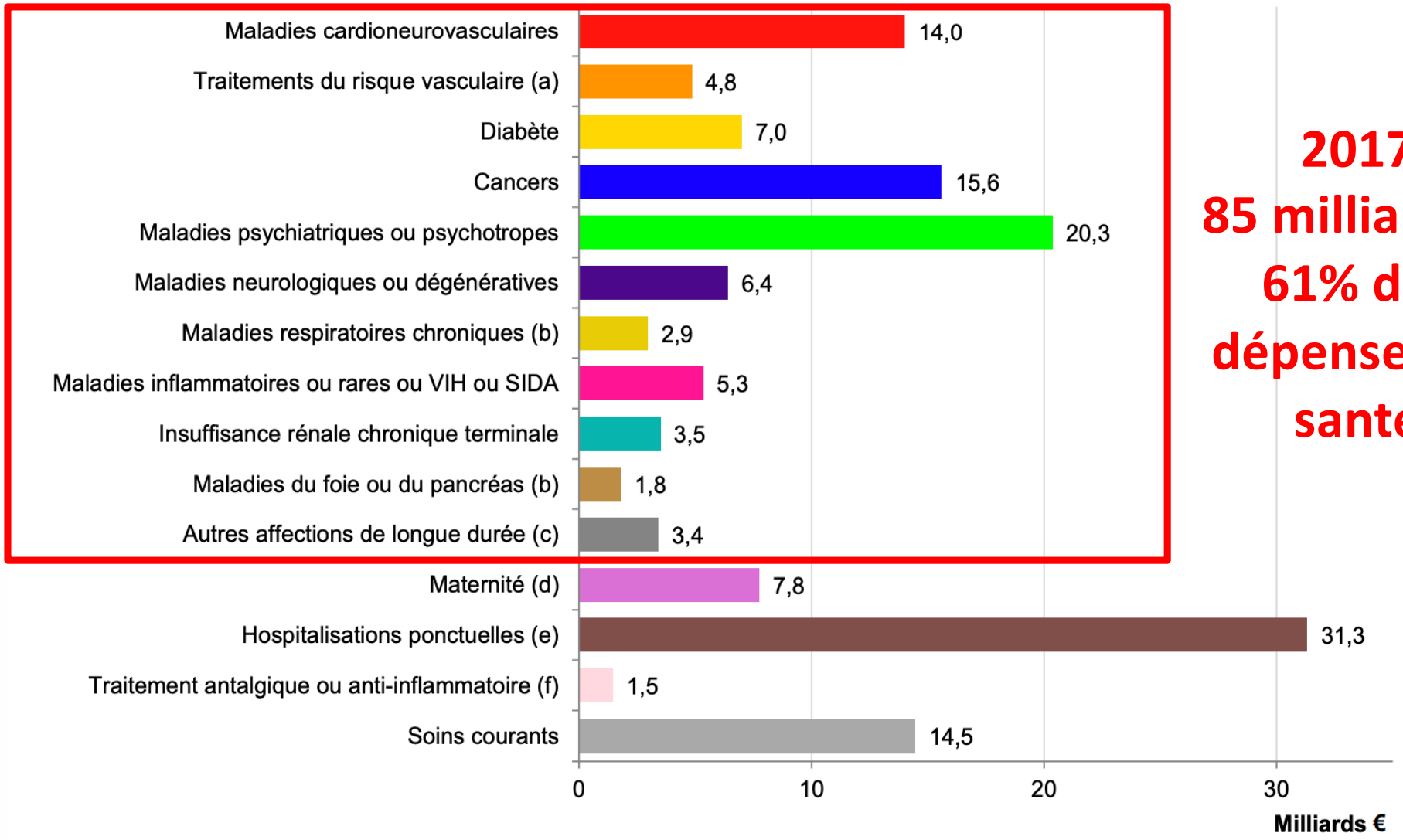
2/3 des personnes atteintes par une maladie chronique ont une limitation dans la vie courante

CESE : Conseil Economique, Social et Environnemental

3ème assemblée de la république, consultative, membres désignés représentant la société civile. il conseille le Gouvernement et le Parlement et participe à l'élaboration et à l'évaluation des politiques publiques dans ses champs de compétences.

Affectation des dépenses de santé par pathologies, traitements, hospitalisations

En milliard d'euros - Régime général (soit près de 9 assurés sur 10)



2017
85 milliards €
61% des dépenses de santé

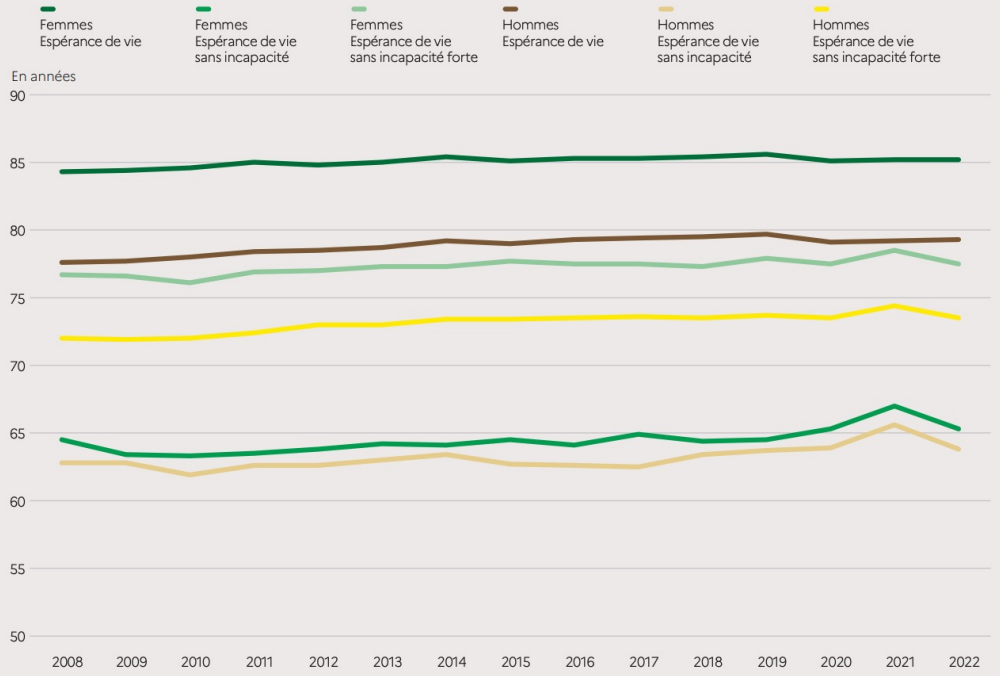
Figure 4 : Répartition des dépenses d'assurance maladie remboursées en 2022 par catégorie de pathologies, traitements chroniques et épisode de soins : 190,3 milliards d'euros pour l'ensemble des régimes



2022
112 milliards €
59 % des dépenses de santé

Prise en compte du handicap et de l'incapacité: les années de vie perdues corrigée de l'incapacité ou l'Espérance de Vie Sans Incapacité (EVSI)

Graphique 2 Espérance de vie et espérance de vie sans incapacité à la naissance par sexe, de 2008 à 2022



Lecture > L'espérance de vie à la naissance s'élève à 79,3 ans pour les hommes et à 85,2 ans pour les femmes en 2022. L'espérance de vie sans incapacité à la naissance est de 63,8 ans pour les hommes et de 65,3 ans pour les femmes en 2022.
Champ > France.
Source > Insee, Statistiques d'état civil et données issues de l'enquête Statistiques sur les revenus et les conditions de vie (SRCV).
> *Études et Résultats* n° 1290 © DREES

The health state of France before COVID-19 pandemic between 1990 and 2019: an analysis of the Global Burden of Disease study 2019

Florence Francis-Oliviero,[a,b,c,*] Panayotis Constantinou,[d] Romana Haneef,[e] French GBD Collaborators, Michaël Schwarzinger,[b,f] Anne Gallay,[e] Antoine Rachas,[d] and François Alla[b,c,f]

Les années de vie perdues (YLLs)

Legend:
Communicable, maternal, neonatal and nutritional
Non-communicable
Injuries

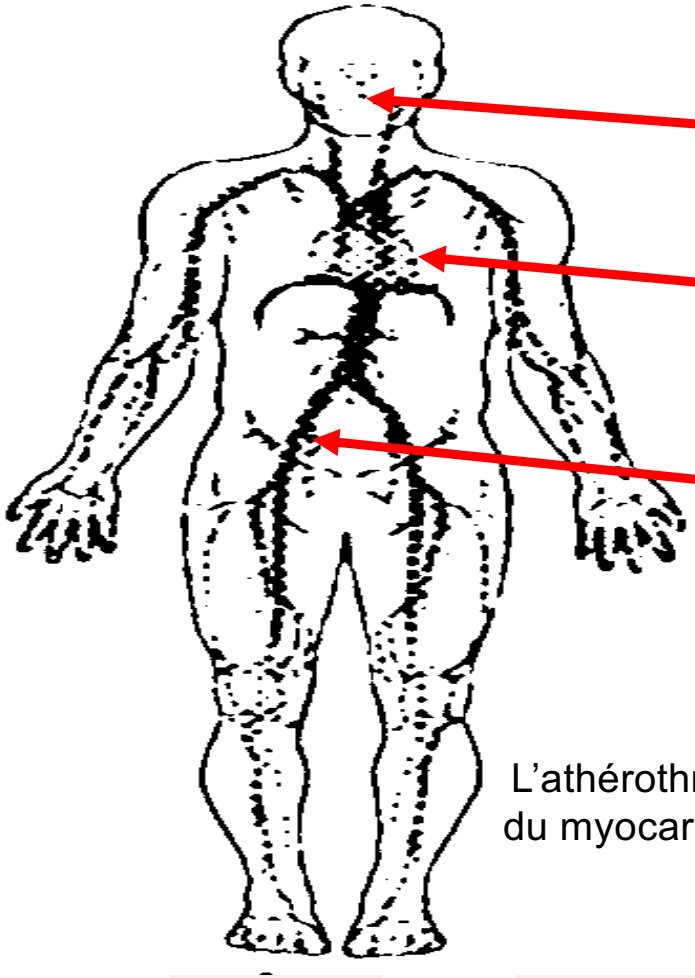
a

Leading causes 1990	Age-standardized Rate YLLs 1990	Leading causes 2019	Age-standardized Rate YLLs 2019
1 Ischemic heart disease	1,438.0 (1,367.0 to 1,498.2)	1 Lung cancer	771.2 (722.8 to 818.4)
2 Road injuries	1,017.9 (991.8 to 1,044.1)	2 Ischemic heart disease	593.3 (545.6 to 632.1)
3 Stroke	909.7 (849.9 to 952.2)	3 Self-harm	519.3 (487.1 to 563.1)
4 Self-harm	898.8 (873.7 to 924.7)	4 Stroke	357.2 (317.6 to 389.1)
5 Lung cancer	823.2 (800.0 to 845.9)	5 Colorectal cancer	308.1 (282.5 to 330.4)
6 Cirrhosis	526.3 (509.3 to 543.2)	6 Road injuries	298.1 (273.5 to 318.2)
7 Neonatal disorders	483.9 (428.4 to 545.7)	7 Neonatal disorders	293.9 (242.2 to 348.8)
8 Colorectal cancer	455.9 (437.2 to 471.7)	8 Breast cancer	266.4 (245.1 to 286.6)
9 Congenital defects	436.7 (396.9 to 507.4)	9 Cirrhosis	247.5 (229.6 to 268.2)
10 Breast cancer	394.7 (379.7 to 407.4)	10 Alzheimer's disease	219.9 (55.2 to 566.7)
11 Lower respiratory infect	295.5 (275.5 to 310.1)	11 Congenital defects	206.9 (175.8 to 272.6)
12 Falls	294.2 (277.3 to 308.7)	12 Pancreatic cancer	201.0 (183.1 to 219.7)
13 SIDS	286.3 (227.4 to 340.5)	13 Falls	176.2 (162.0 to 189.5)
14 COPD	274.9 (249.5 to 294.2)	14 Lower respiratory infect	150.0 (131.5 to 165.1)
15 HIV/AIDS	249.2 (243.7 to 255.3)	15 COPD	141.3 (121.5 to 173.7)
16 Other malignant neoplasms	230.4 (162.4 to 246.6)	16 Other malignant neoplasms	137.3 (117.0 to 151.7)
17 Other cardiovascular	226.4 (210.8 to 239.5)	17 Alcohol use disorders	132.7 (114.4 to 147.9)
18 Alzheimer's disease	218.6 (53.3 to 595.6)	18 Brain cancer	131.8 (75.4 to 154.9)
19 Stomach cancer	202.7 (194.6 to 210.0)	19 Liver cancer	130.7 (114.7 to 148.8)
20 Esophageal cancer	197.7 (190.5 to 205.2)	20 Leukemia	124.9 (115.4 to 133.8)

Université Paris Cité

Les maladies cardiovasculaires

Athérothrombose: 3 principales complications cliniques de la maladie selon la localisation



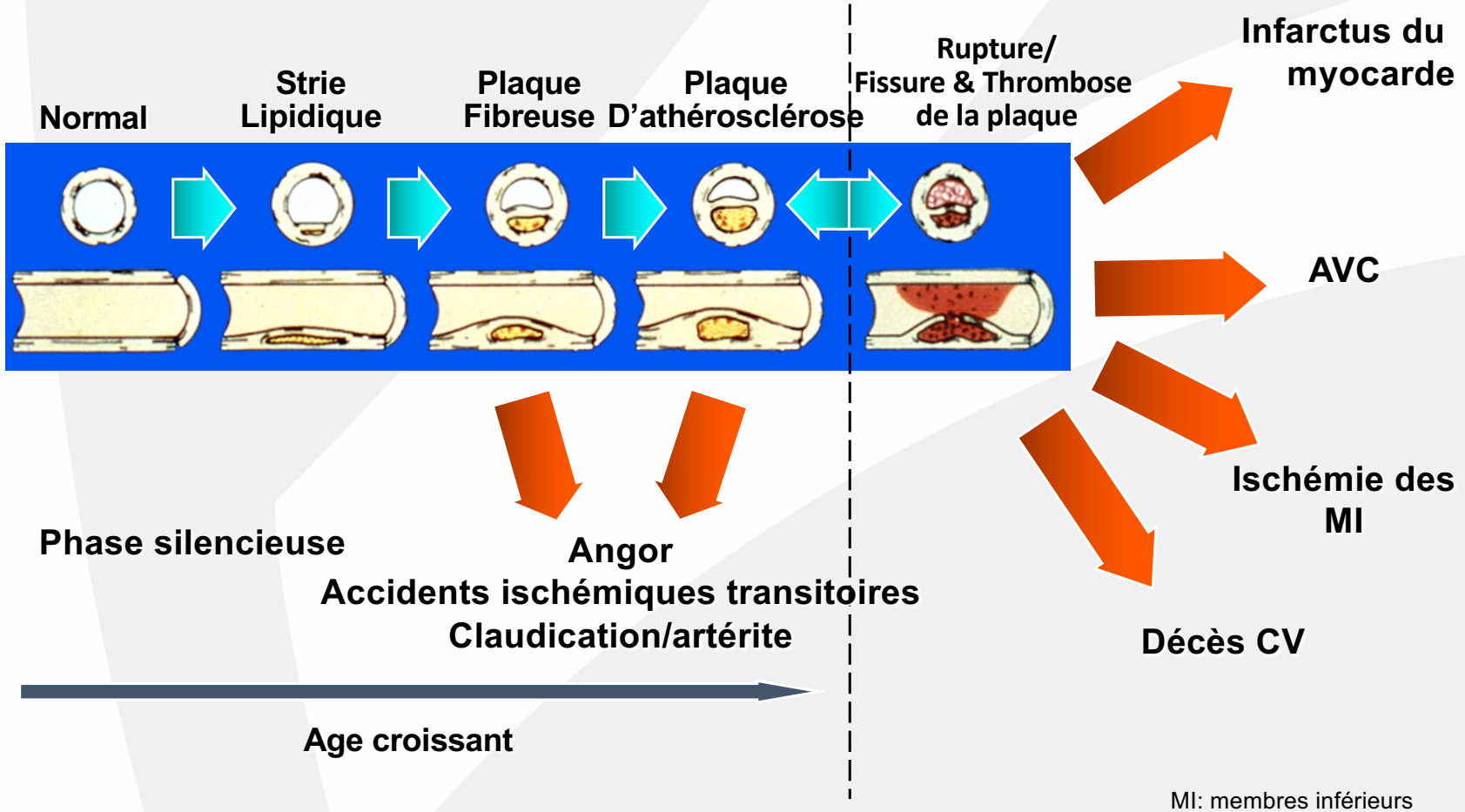
Accident Vasculaire Cérébral

Infarctus du myocarde

Artérite des membres inférieurs

L'athérothrombose est la cause quasi-exclusive des infarctus du myocarde et de l'artérite des membres inférieurs, mais elle n'est qu'une des causes d'AVC

Athérosclérose et Athérothrombose: Une maladie d'évolution lente et progressive



MI: membres inférieurs

Université Paris Cité

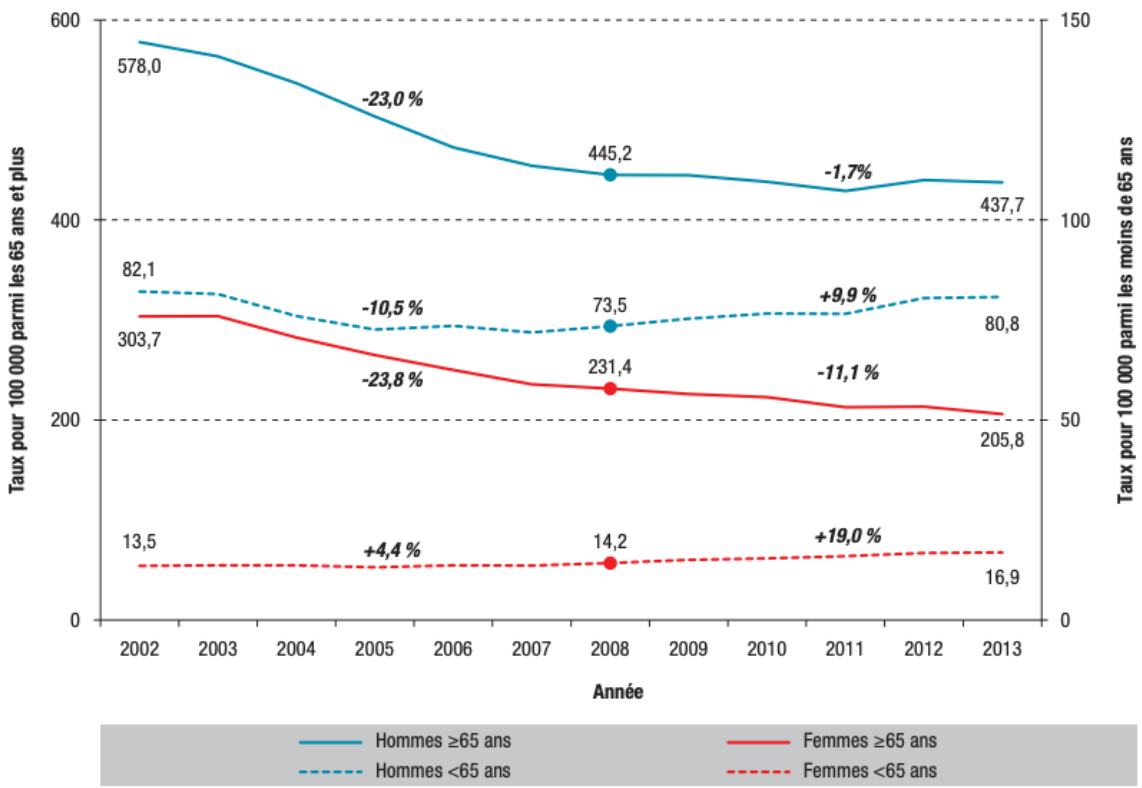
Les maladies cardiovasculaires et neurovasculaires

- Recouvrent : cardiopathies ischémiques (dont les infarctus du myocarde), accidents vasculaires cérébraux, insuffisance cardiaque, les artériopathies périphériques, …
- 1ère cause de mortalité dans le monde
- 2ème cause de mortalité en France



Infarctus du myocarde : une évolution préoccupante chez la femme de moins de 65 ans

Évolution des taux standardisés* de patients hospitalisés pour infarctus du myocarde selon le sexe et l'âge, 2002-2013, France entière



* Taux standardisés sur la structure d'âge de la population française de 2010.
Note : Les taux standardisés parmi les personnes âgées de moins de 65 ans et celles âgées de 65 ans ou plus sont représentés sur les axes des ordonnées gauche et droite respectivement, avec des échelles différentes.

Université Paris Cité

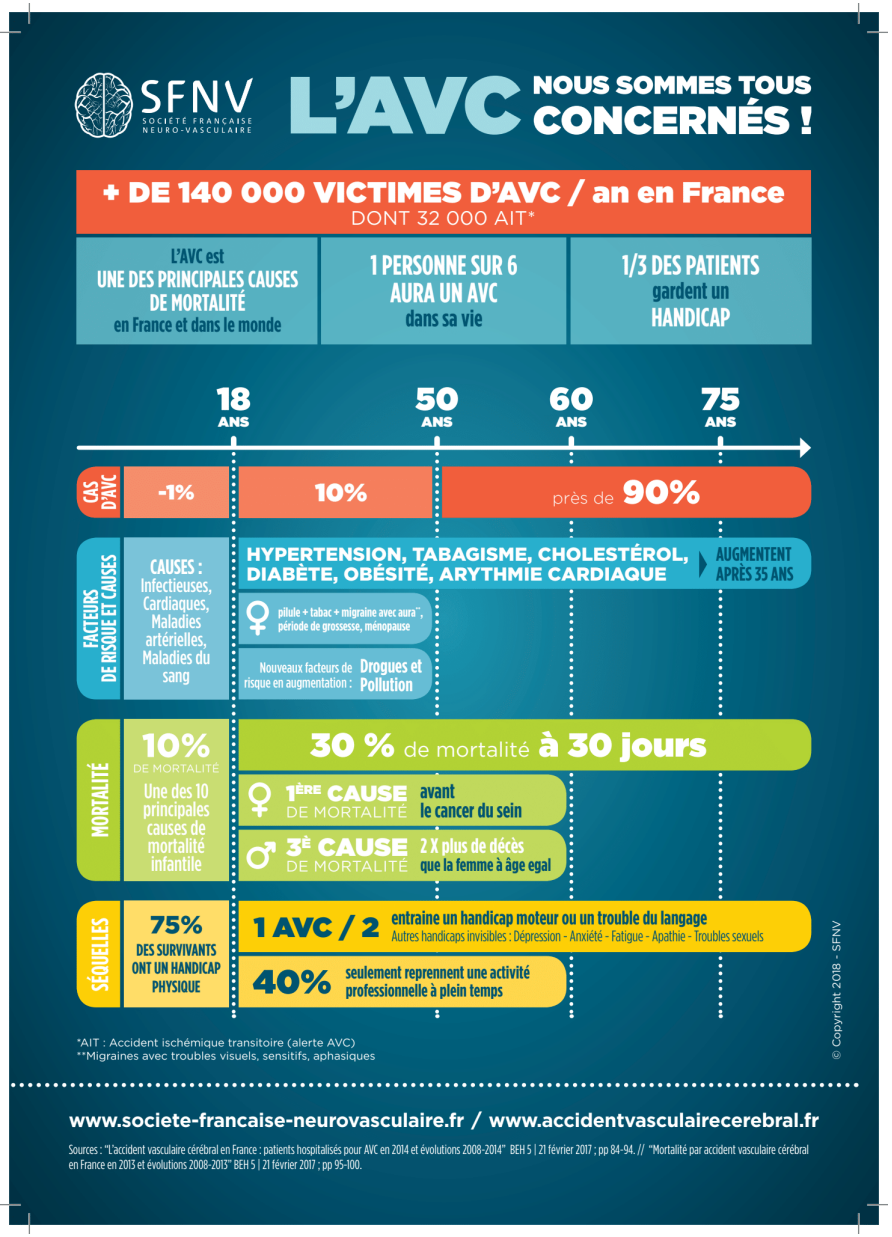
Accident Vasculaire cérébral

Les accidents vasculaires cérébraux (AVC) recouvrent un ensemble de syndromes se manifestant par l'apparition brutale d'un déficit neurologique dû à des lésions cérébrales d'origine vasculaire.

On distingue deux grands types d'AVC :

- Les AVC ischémiques ou infarctus cérébraux (80% des AVC) consécutifs à l'obstruction d'une artère cérébrale
- Les AVC hémorragiques (20% des AVC), dus à une rupture d'un vaisseau sanguin cérébral.

Les accidents ischémiques transitoires (AIT) sont des accidents vasculaires d'origine ischémique caractérisés par la régression précoce et complète des déficits neurologiques, ainsi que par l'absence d'image d'infarctus cérébral.



Université Paris Cité

Principaux facteurs de risque

Facteurs principaux

- **Age**
- **Sexe**
- Tabac (cf. cours FDR comportementaux)
- Diabète
- Hypertension artérielle
- Dyslipidémies
- **Hérédité**

En orange: les facteurs de risque non modifiables

Facteurs plus discutés

- Sédentarité ? (cf. cours FDR comportementaux)
- Obésité ?
- Stress ? Isolement ?
- Environnement travail (bruit, températures extrêmes …)
- Nutrition ? (cf. cours FDR comportementaux)
- Facteurs socio-économiques ?

Ces facteurs de risque ne sont peut-être pas “indépendants” des facteurs de risque principaux

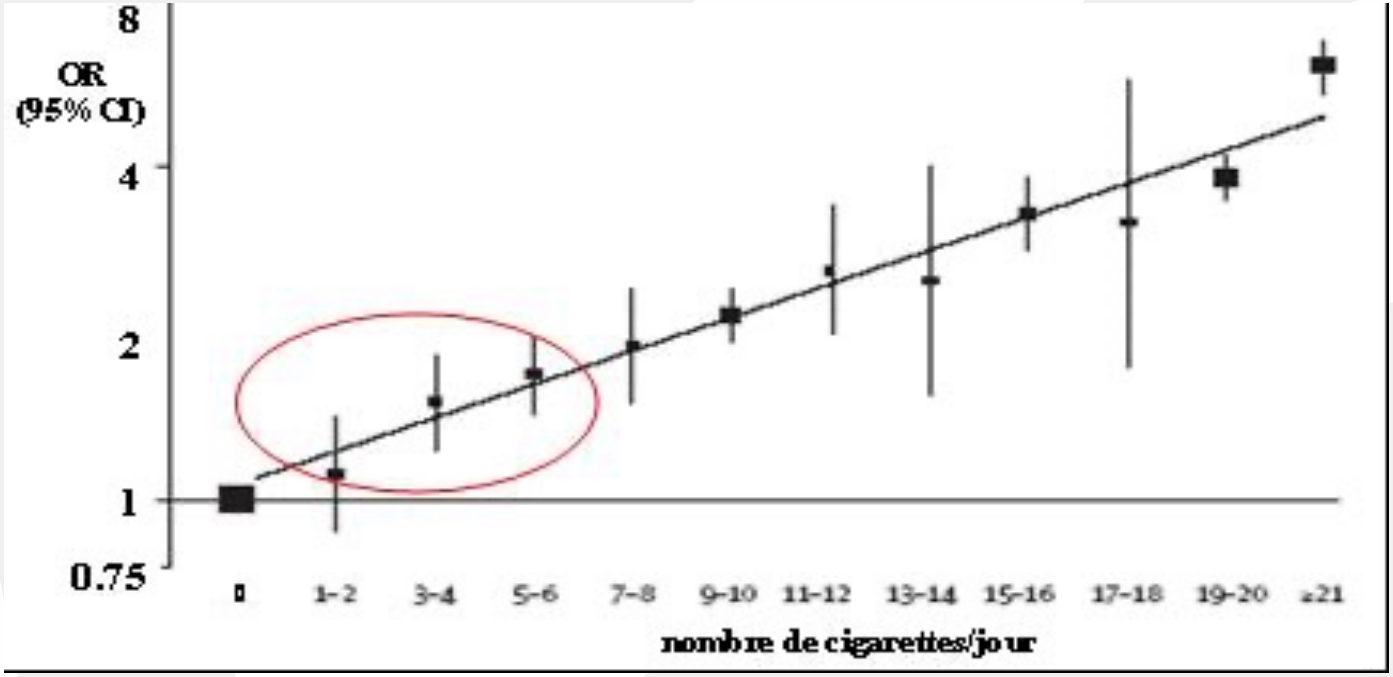
L'étude de Framingham : une étude épidémiologique longitudinale, grandeur nature, débutée en 1948 et qui continue



Une cohorte caractérisée de façon précise sur le plan clinique et biologique et suivie longitudinalement

3 générations consécutives ont maintenant été étudiées

Risque d'infarctus du myocarde en fonction du nombre de cigarettes/jour : la relation est continue, quantitative et linéaire



Il n'y a pas de seuil de consommation au dessous duquel il n'y ait aucun risque. Même la consommation de quelques cigarettes par jour (cercle rouge) augmente significativement le risque d'infarctus du myocarde

OR: odds ratio (rapport des cotes)

Université Paris Cité

Diabète

Le diabète sucré est une affection métabolique caractérisée par une hyperglycémie chronique (taux de glucose dans le sang trop élevé) liée à une déficience soit de la sécrétion de l'insuline, soit de l'action de l'insuline, soit des deux. Il existe différents types de diabète :

- **Le diabète de type 2** est la forme la plus fréquente du diabète. Il est caractérisé par une résistance à l'insuline et une carence relative de sécrétion d'insuline. Cette forme de diabète survient essentiellement chez les adultes d'âge mûr mais peut également survenir à un âge plus jeune, voire même pendant l'adolescence.

- **Le diabète de type 1**, beaucoup moins fréquent, est principalement causé par la destruction des cellules bêta du pancréas, d'où l'incapacité de la personne a
essentiellement chez les enfants et les jeunes adult



Université Paris Cité

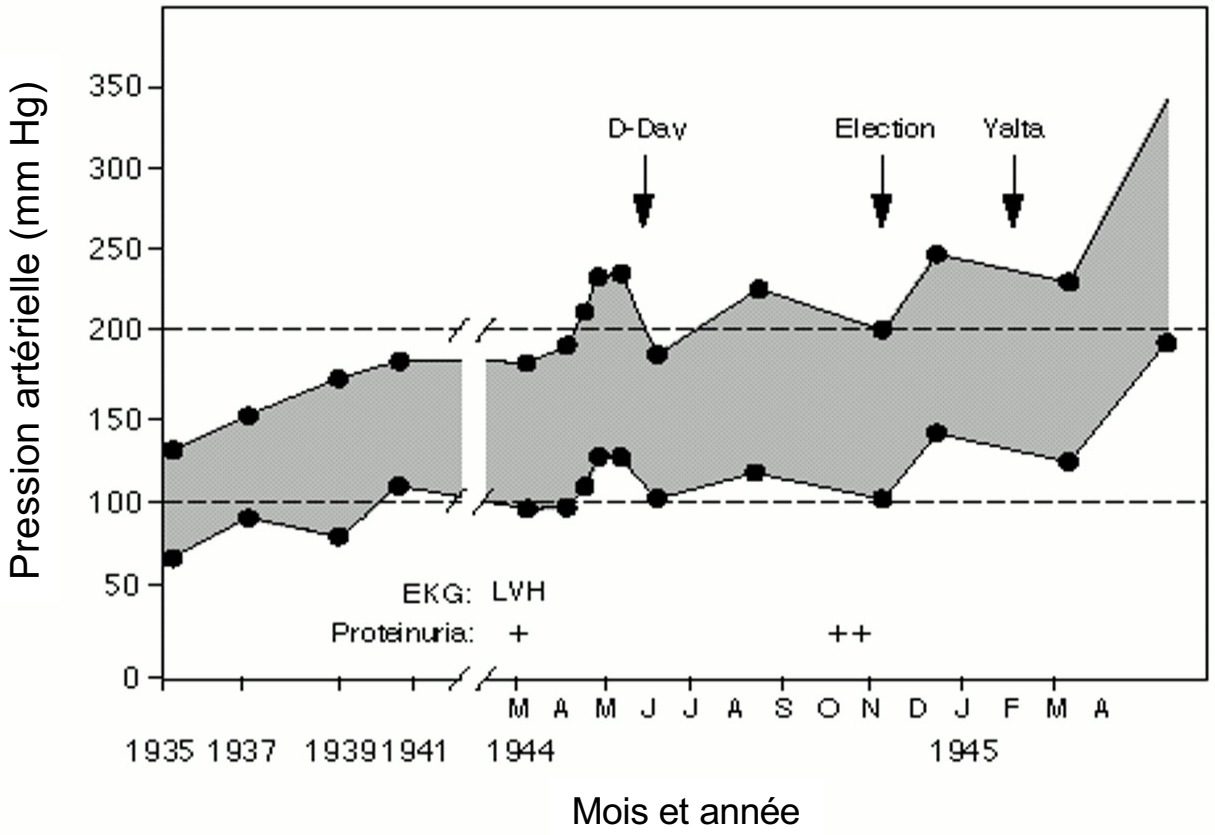
Hypertension artérielle

Elle est définie par une élévation persistante de la pression artérielle systolique ≥140 mmHg ou de la pression artérielle diastolique ≥90 mmHg.

Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), **62 % des affections vasculaires cérébrales et près de la moitié des cardiopathies ischémiques sont attribuées à une pression artérielle élevée**.



Mesures de Pression Artérielle Diastolique et Systolique de Franklin D. Roosevelt de 1935 à sa mort le 12 Avril 1945





Churchill, Roosevelt, Staline à Yalta

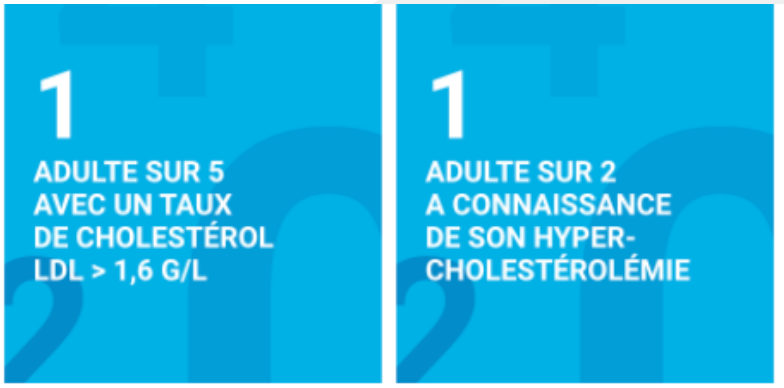
L'hémorragie cérébrale qui a tué FDR avait été précédée de longues années d'hypertension très sévère

Messerli F. ***N Engl J Med*** 1995;332:1038-1039

Université Paris Cité

Dyslipidémies : hypercholestérolémie

L'hypercholestérolémie est un trouble métabolique qui se traduit par un taux élevé de cholestérol LDL. Le cholestérol-LDL est la fraction la plus athérogène du cholestérol : en excès, il tend à s'accumuler dans la paroi artérielle et à favoriser le développement de la plaque d'athérome.
L'hypercholestérolémie est, de ce fait, avec l'hypertension artérielle, l'obésité et le diabète l'un des principaux facteurs de risque cardiovasculaire.



Université Paris Cité

Obésité

L'obésité correspond à un excès de masse grasse et à une modification du tissu adipeux, entraînant des inconvénients pour la santé et pouvant réduire l'espérance de vie.

Ses causes sont complexes. Elle résulte de l'intrication de plusieurs facteurs − alimentaires, génétiques épigénétiques et environnementaux − impliqués dans le développement et la progression de cette maladie chronique.

IMC (en kg/m2)	Classification OMS
Moins de 16,5	Dénutrition
Entre 16,5 et 18,5	Maigreur
Entre 18,5 et 25	**Valeur de référence**
Entre 25 et 30	Surpoids
Entre 30 et 35	Obésité modérée
Entre 35 et 40	Obésité sévère
Au-delà de 40	Obésité massive

L'obésité concerne

17% **des adultes en France**

(13% dans le monde)

De nombreuses complications

✔Diabète de type 2, ✔maladies cardiovasculaires, ✔hépatiques, ✔rénales, ✔cancers, ✔respiratoires, ✔articulaires, ✔dermatologiques...



- des **causes** multiples
- des **mécanismes biologiques** variés pas encore tous entièrement élucidés

Université Paris Cité

L'obésité abdominale



Mesure du périmètre abdominal

> 100 cm chez l'homme

> 88 cm chez la femme

Correspond à un excès de masse grasse autour des viscères

Risque accru de diabète, maladie cardiovasculaires, cancers

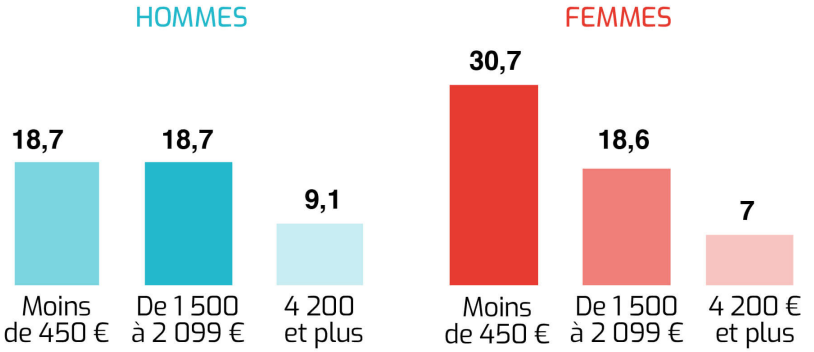
Université Paris Cité

Prévalence de l'obésité

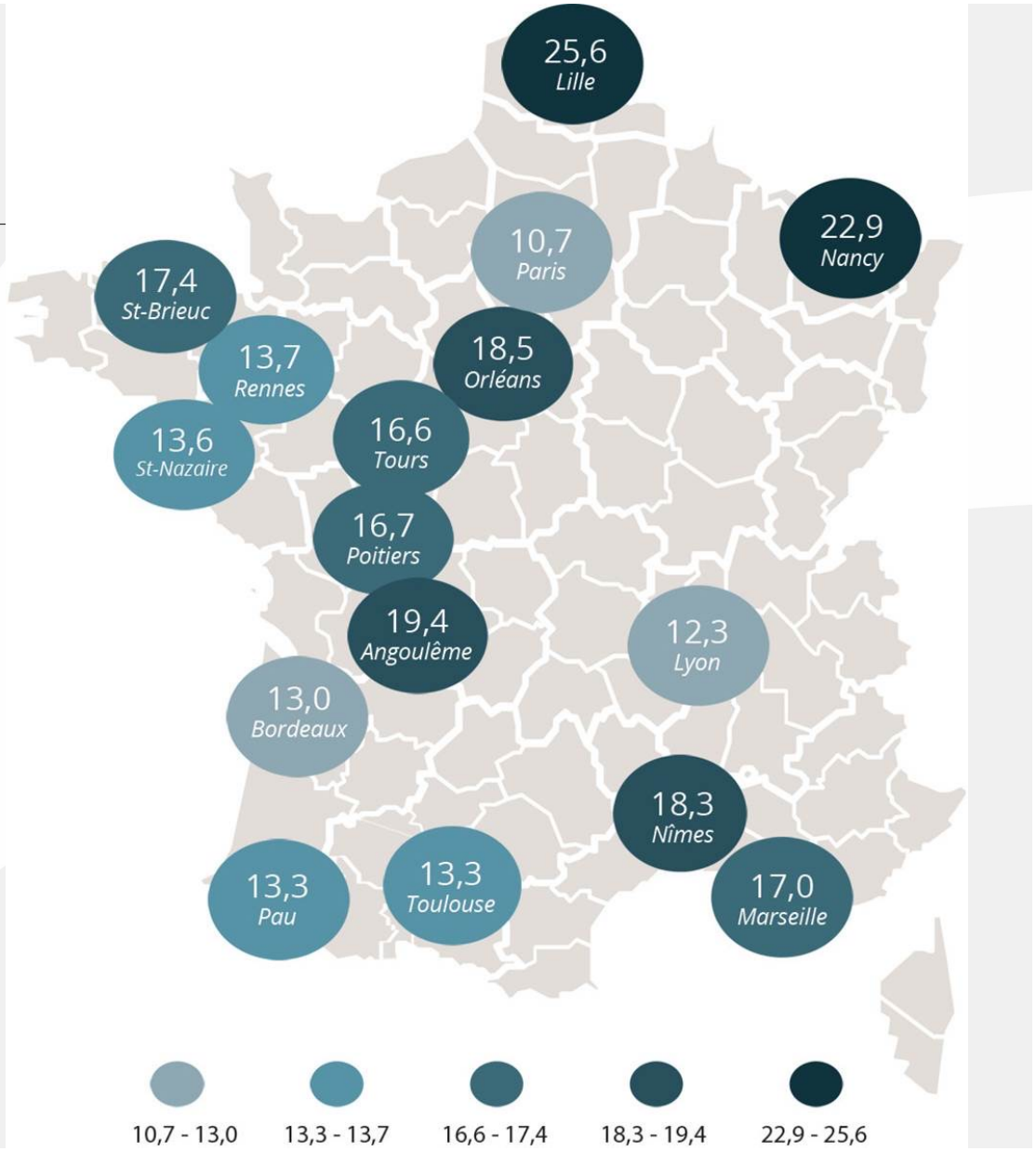
Inégalités géographiques marquées
Liées aux niveaux de vie les plus bas

(BEH 2016. Cohorte Constances)

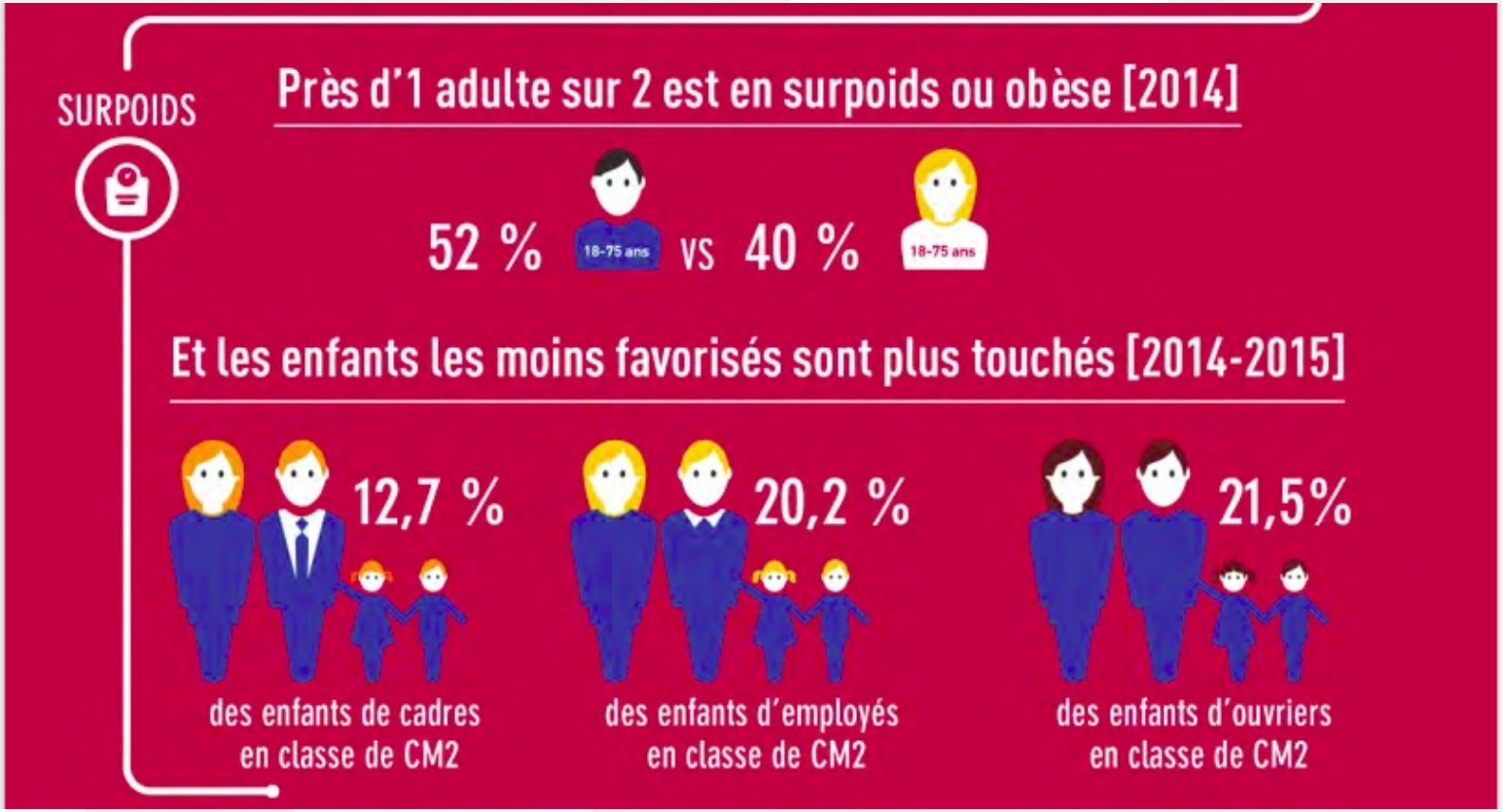
PRÉVALENCE DE L'OBÉSITÉ EN FONCTION DU REVENU MENSUEL, EN %
Une forte corrélation avec le niveau de revenu



Source schéma : Santé publique France, "Bulletin épidémiologique Hebdomadaire", 25 octobre 2016.



Eléments d'analyse selon le sexe, l'âge, la catégorie sociale

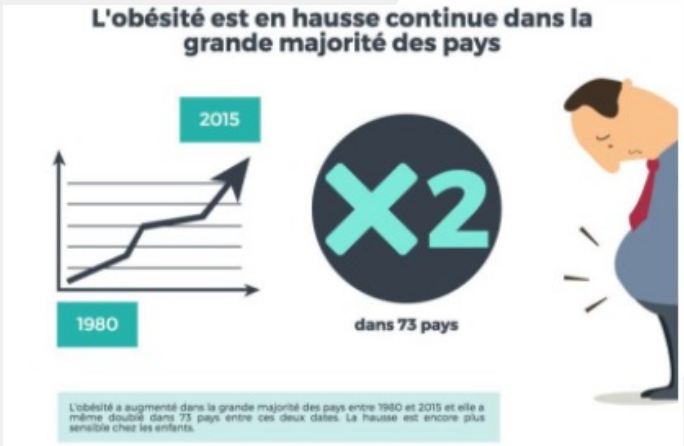


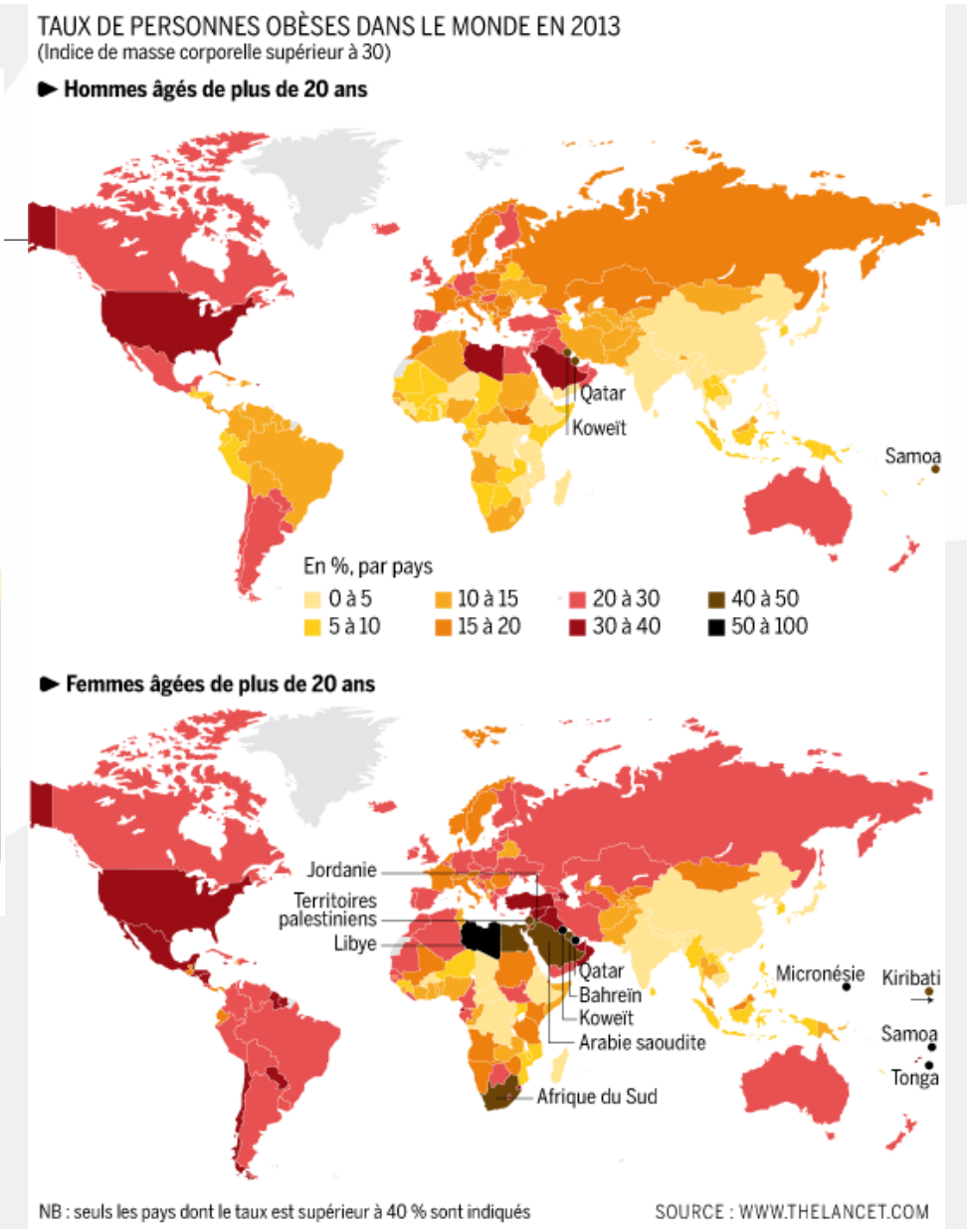
D

Il existe une véritable « épidémie » d'obésité



December 13-19, 2003





Université Paris Cité

Les maladies cardio-vasculaires

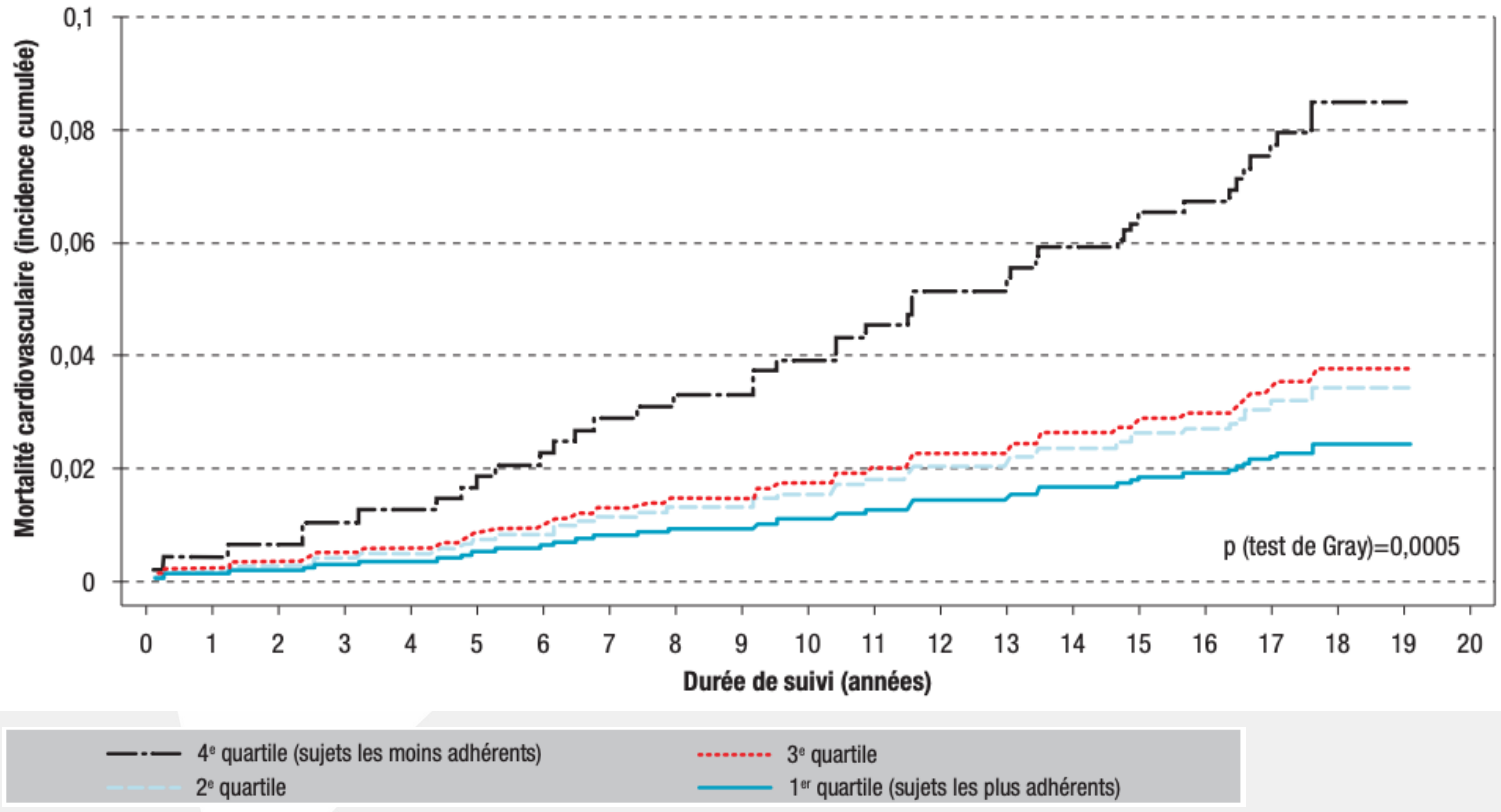
- Prévention :

  - Agir sur les facteurs modifiables :

    - PNRT : Plan National de Réduction du Tabagisme
    - PSSBE : Plan Santé Sport et Bien-Etre
    - PNNS : Plan National Nutrition Santé
    - Plan de santé au travail
    - Plan National de Santé Publique 2020

Université Paris Cité

Courbes de survie non ajustées entre le score d'adhésion aux recommandations européennes de prévention cardiovasculaire et la mortalité cardiovasculaire **France**



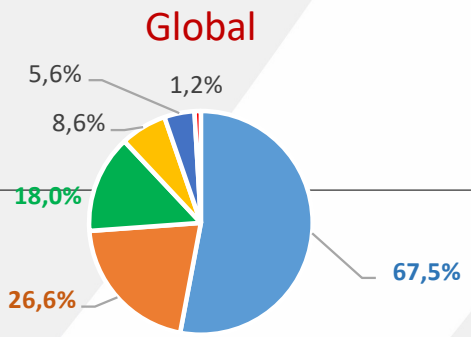
Université Paris Cité

Les morts violentes

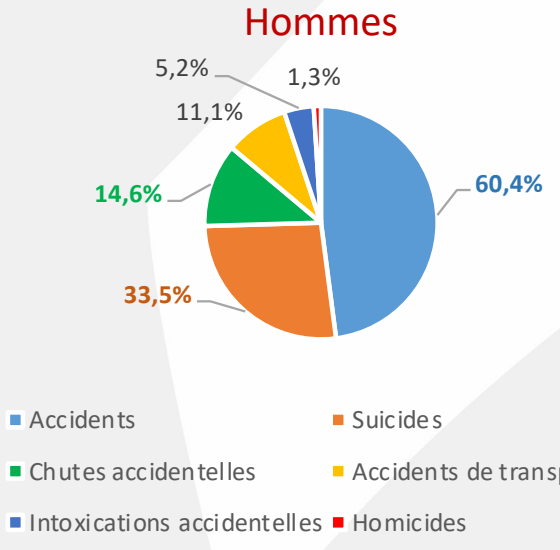
6,5 % des causes de décès (Rapport 2017 de la DREES)

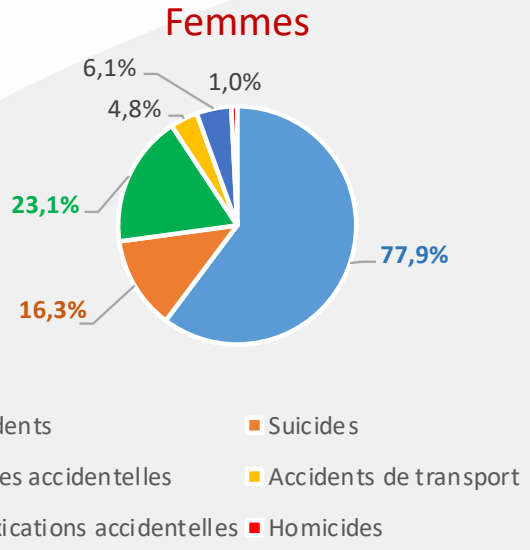
- Accidents
- Accidents de transport
- Chutes accidentelles
- Intoxications accidentelles
- Suicides
- Homicides

Université Paris Cité



(DREES, Rapport 2017)





Université Paris Cité

La santé mentale

D'après les projections de l'Organisation mondiale de la santé, en 2020, le fardeau global (mortalité + incapacités) des troubles mentaux représentera au niveau mondial 15 % de la charge de l'ensemble des maladies, et la dépression deviendra la principale cause d'invalidité.

Il y a quelques années, une méta-analyse des données de la littérature internationale présentait déjà le syndrome dépressif comme étant la deuxième cause d'années de vie perdues en bonne santé.

Par ailleurs, le coût social et financier de la dépression serait aggravé par les nombreuses comorbidités associées (en particulier les maladies cardiaques et coronariennes) et par son impact négatif sur les habitudes de vie (par exemple usages de substances psychoactives, sédentarité, troubles du comportement alimentaire, pratiques sexuelles à risques)

Université Paris Cité

La santé mentale

- Que la pathologie (dépression, trouble bipolaire, autisme, schizophrénie, anxiété, addiction) soit chronique ou aiguë, **12 millions de personnes souffrent de troubles psychiatriques en France et sont concernées par plusieurs comportements à risque**

- Selon l'OMS, un Européen sur 4 est touché par des troubles psychiques au cours de sa vie

Université Paris Cité

Les chiffres clés de la dépression



Les chiffres clés sur les conduites suicidaires



Les chiffres-clés de la souffrance psychique et épuisement professionnel



Université Paris Cité

La santé mentale

- Les troubles mentaux (maladies psychiatriques ou consommations de psychotropes) représentent **le premier poste de dépenses du régime général de l'assurance maladie** par pathologie, avant les cancers et maladies cardio-vasculaires, soit 19,3 milliards d'euros

- **Le coût économique et social des troubles mentaux est évalué à 109 milliards d'euros par an**, dont :
    - 65 milliards pour la perte de qualité de vie,
    - 24,4 milliards pour la perte de productivité liée au handicap et aux suicides,
    - 13,4 milliards dans le secteur médical,
    - 6,6 milliards pour le secteur médico-social

Université Paris Cité

La santé mentale

- Les personnes ayant des troubles psychiques sévères et persistants souffrent généralement **d'un grand isolement**, d'une perte de capacité à entreprendre, à vivre dans un logement autonome, à tenir un emploi et à réaliser les actes de la vie quotidienne et souvent une rupture des liens familiaux et sociaux.

- Ces effets, conjugués à la stigmatisation et, le cas échéant, à des hospitalisations prolongées et répétées en psychiatrie, elles-mêmes facteur de désinsertion sociale, amènent fréquemment les personnes à la perte de leur logement, **à l'errance et à l'exclusion sociale**.

- Cela a pour conséquence **une réduction de l'espérance de vie** estimée à 16 ans pour les hommes et 13 ans pour les femmes

Université Paris Cité



- Promouvoir le bien être mental, prévenir et repérer précocement la souffrance psychique et prévenir le suicide
- Garantir des parcours de soins coordonnés et soutenus par une offre en psychiatrie accessible, diversifiée et de qualité
- Améliorer les conditions de vie et d'inclusion sociale et la citoyenneté des personnes en situation de handicap psychique

Université Paris Cité

Les grands problèmes de santé

Approche par le risque

Le risque est la probabilité de survenue d'une maladie au sein d'une population.

Un FDR d'une maladie est un facteur qui modifie la probabilité de survenue de cette maladie en cas d'exposition.

Parmi les FDR identifiés, certains sont accessibles à la prévention, et d'autres sont non modifiables, tels le sexe, l'âge ou certaines prédispositions génétiques.

Le rapport de l'OMS sur la santé mentionne six facteurs de risque liés aux comportements parmi les dix facteurs de risque principaux contribuant à la charge de morbidité dans les pays développés. Ces facteurs comportementaux contribuent le plus à la mortalité prématurée et évitable et peuvent être la cible d'actions de prévention

Université Paris Cité

Les grands problèmes de santé

Approche par le risque

- Les comportements à risque : cf. cours 5

Les comportements à risque pour la santé sont des comportements volontaires ou involontaires, souvent répétitifs, ayant des conséquences négatives sur la santé et susceptibles de mettre en danger les individus sur le plan physique, psychologique ou social.

- les groupes à risque

Université Paris Cité

Approche des problèmes de santé par les populations à risque

Les nourrissons et les jeunes enfants

Les adolescents et les jeunes adultes

Les personnes âgées

Les populations précaires *(cf. cours Morgane Michel)*

Université Paris Cité

Approche des problèmes de santé par les populations à risque

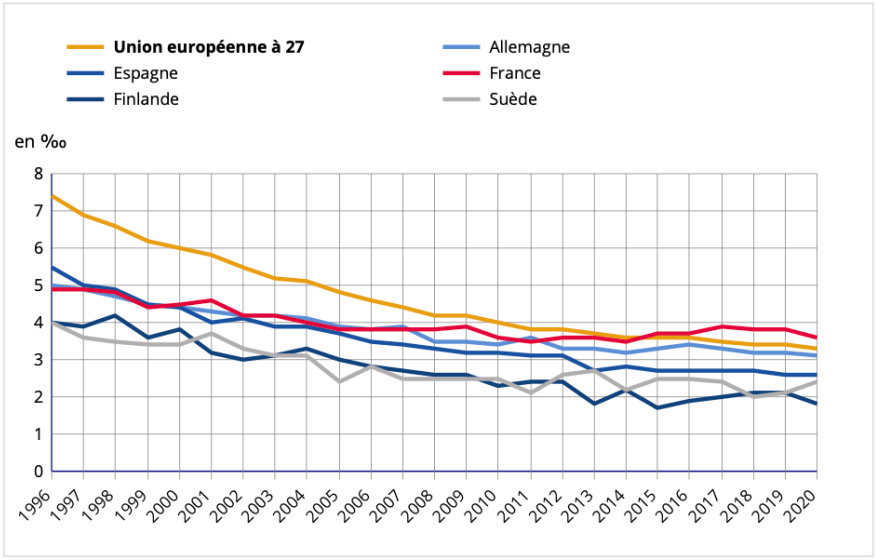
La périnatalité

Le taux de mortalité infantile augmente en France : 3,9/1000 en 2021

Il est passé **au-dessus de la moyenne européenne !**

Divers risques identifiés : survie augmentée (heures, jours) de plus grands prématurés, hausse de l'âge des mères, hausse du nombre de naissances multiples, surpoids et/ou tabagisme durant la grossesse, précarité sociale,...

Figure 4 – Taux de mortalité infantile pour 1 000 naissances vivantes dans l'Union européenne de 1996 à 2020



Lecture : en 2020, dans l'Union européenne, pour 1 000 naissances vivantes, 3,3 enfants décèdent avant leur premier anniversaire.
Champ : naissances vivantes en Union européenne à 27 pays, France hors Mayotte jusqu'en 2013, France à partir de 2014.
Sources : Eurostat ; Insee (pour la France).

Université Paris Cité

Approche des problèmes de santé par les populations à risque

Les nourrissons et les jeunes enfants

Les nourrissons et jeunes enfants sont exposés à un sur-risque en santé au travers des comportements de l'entourage pouvant faire **défaut dans la sécurisation de leur environnement.**

Les accidents de la vie courante, principale cause de décès avant l'âge de 15 ans (300 décès par an), se produisent au domicile, à l'école ou pendant le sport.

Université Paris Cité

Approche des problèmes de santé par les populations à risque

Les adolescents et les jeunes adultes

Les neurosciences ont démontré qu'en raison d'un déséquilibre de maturation des différentes régions du cerveau, l'adolescence est la période de développement pendant laquelle les individus possèdent **la plus grande propension à prendre des risques**.

Chez les jeunes de 17 ans : 25 % de fumeurs quotidiens de **tabac**, 8,4 % de consommateurs réguliers **d'alcool** (au moins dix fois dans le mois) et 7,2 % d'usagers réguliers de **cannabis**.

La mortalité par **suicide** représente 15 % des causes de décès parmi les 15-24 ans.

Université Paris Cité

Approche des problèmes de santé par les populations à risque

Les personnes âgées

La part des 75 ans et plus est de 9,1 % en 2015 et atteindra 14,6 % de la population française en 2040. À partir de 2030, 40 000 personnes âgées en **perte d'autonomie** sont attendues par an, soit un doublement du nombre par rapport à aujourd'hui, laissant présager une augmentation du nombre de 1,2 million en 2012 à 2,3 millions d'ici 2060.

Développée par les gériatres, la **notion de fragilité** s'applique aux personnes âgées vulnérables d'un point de vue **médical et social**. Elle ouvre la voie à des actions de prévention, notamment de **dépistage et de lutte contre la dépendance**, afin de leur permettre de jouir d'un état de bien-être préservant les capacités à marcher, sortir, avoir des activités de loisir, mémoriser.

Bien vieillir est un enjeu pour avancer en âge sereinement. Des informations à l'attention des personnes et des professionnels sont accessibles via le site pourbienvieillir.fr

Université Paris Cité

Conclusion

Système de santé performant avec un système d'assurance maladie => accès universel.

Amélioration globale de l'état de santé de la population : l'espérance de vie s'est constamment allongée

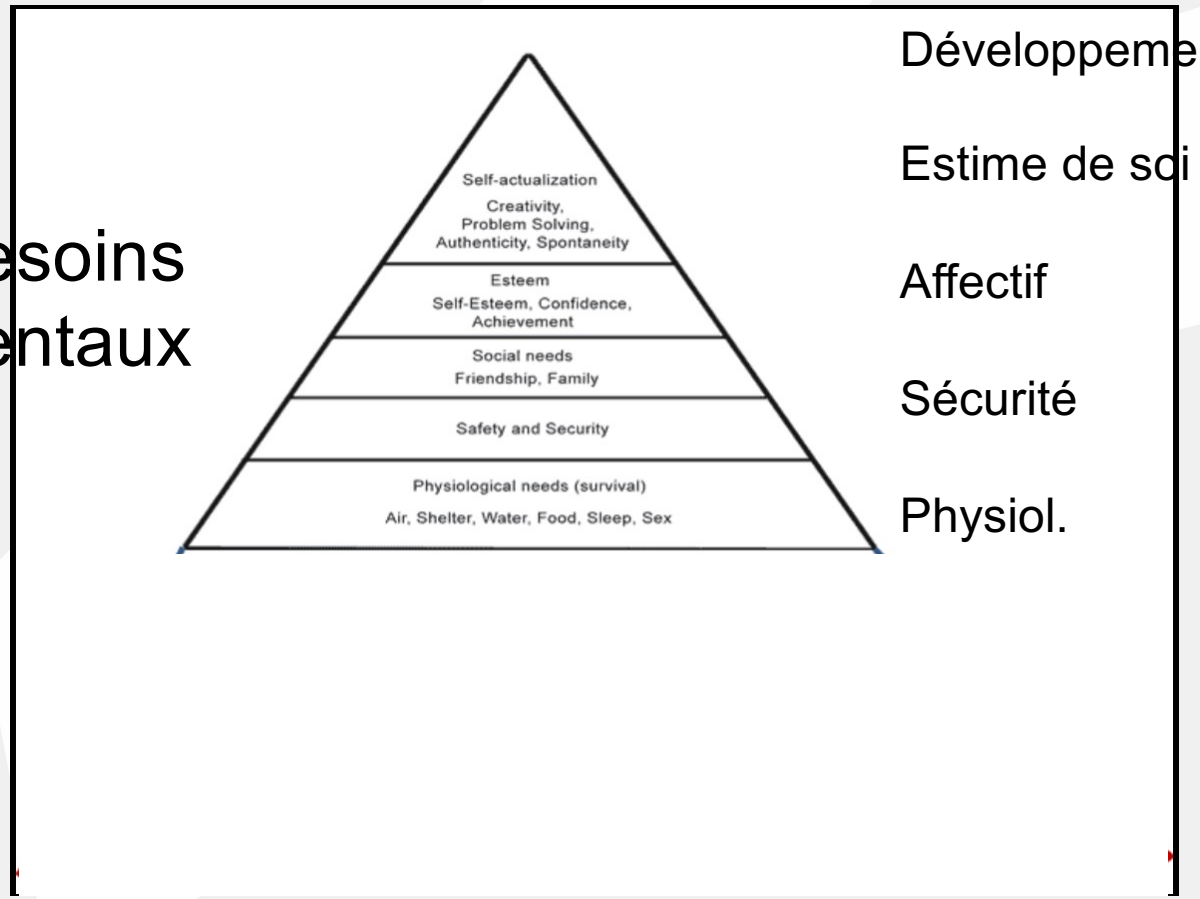
Néanmoins:

- Handicap et perte d'autonomie
- Persistance d'une forte mortalité prématurée
- Les inégalités sociales de santé ont eu tendance à se creuser

La pyramide de Maslow => 5 besoins fondamentaux

Et ….

Les 5 besoins fondamentaux

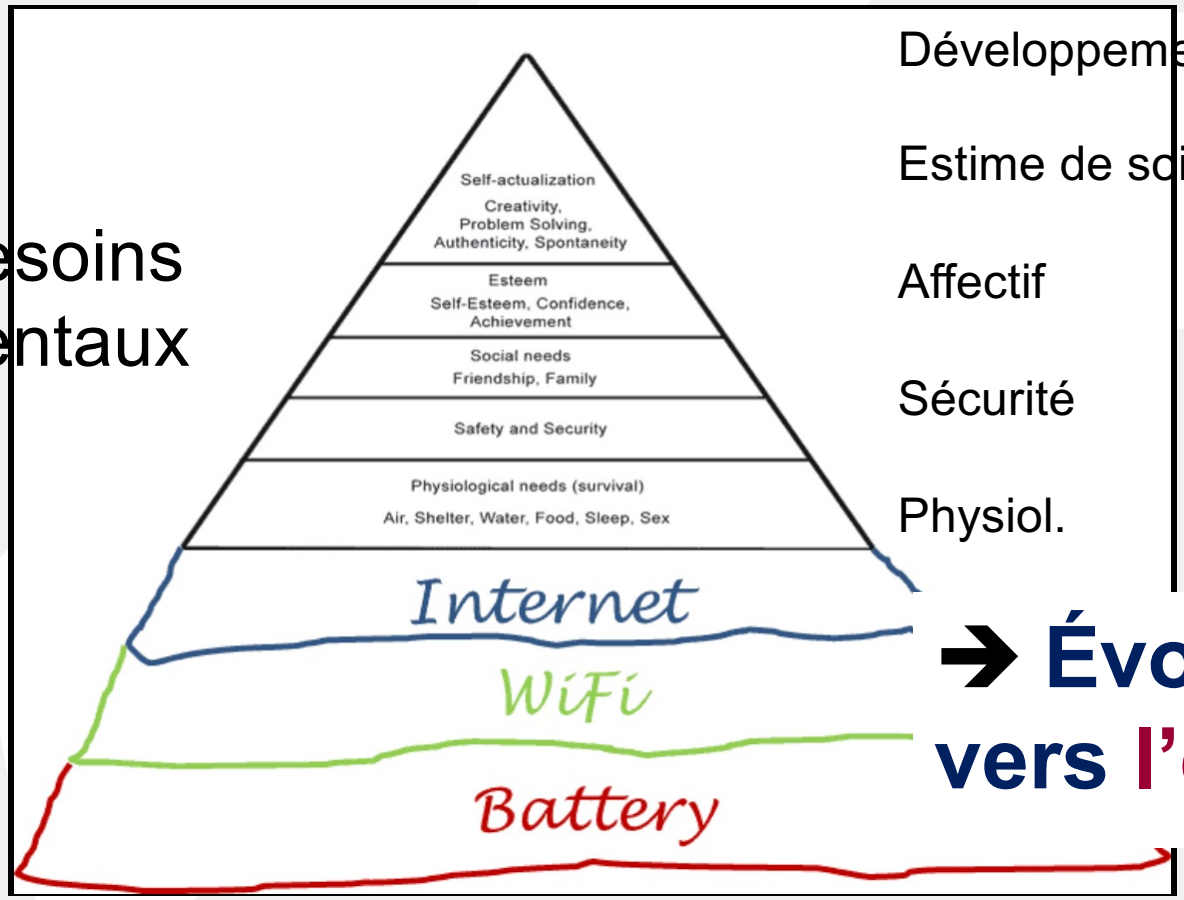


La pyramide de Maslow => 5 besoins fondamentaux

… revisitée au 21e siècle

Et ….

Les 5 besoins fondamentaux



Développement perso

Estime de soi

Affectif

Sécurité

Physiol.

➔ **Évolution vers l'e-santé**